Optimal Untuk Negeri

optimal

*Buku Ajar*

# MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN

*Mutu, Keselamatan Pasien, Dan Tata Kelola TPMB*

Edi Murwani • Budi Astyandini
Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



# BUKU AJAR:
# MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN MUTU, KESELAMATAN PASIEN, DAN TATA KELOLA TPMB

**Penulis:**
Dr. Edi Murwani, Bd., A.Md.Keb., S.Pd., MMRS., FISQua.
Dr. Budi Astyandini, S.SiT. M.Kes.

**Editor:**
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Optimal Untuk Negeri

**Buku Ajar: Manajemen Pelayanan Kebidanan Mutu, Keselamatan Pasien, Dan Tata Kelola TPMB**

**Penulis:**
Dr. Edi Murwani, Bd., A.Md.Keb., S.Pd., MMRS., FISQua.
Dr. Budi Astyandini, S.SiT. M.Kes.

**Editor:**
Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

**Desain Sampul:** Ivan Zumarano
**Penata Letak:** Helmi Syaukani, S.Pd.

**ISBN:** 978-634-7927-15-6

**Cetakan Pertama:** September, 2026

Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
**Copyright © 2026**
**by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri**
*All Right Reserved*

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website: optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

**PENERBIT:**
**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
**Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025**

# PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar *Manajemen Pelayanan Kebidanan: Mutu, Keselamatan Pasien, dan Tata Kelola TPMB* dapat diselesaikan. Buku ini disusun sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, praktisi, serta pengelola pelayanan kebidanan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional, aman, bermutu, dan akuntabel.

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan menuntut bidan tidak hanya memiliki kompetensi klinis, tetapi juga kemampuan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelayanan. Tuntutan tersebut menjadi semakin penting dalam pengelolaan Tempat Praktik Mandiri Bidan atau TPMB yang berhadapan langsung dengan kebutuhan kesehatan perempuan, ibu, bayi baru lahir, anak, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan TPMB perlu dilandasi oleh kepatuhan terhadap regulasi, kewenangan profesi, etika, tata kelola yang baik, serta komitmen terhadap mutu dan keselamatan pasien.

Buku ajar ini membahas manajemen pelayanan kebidanan secara menyeluruh, mulai dari konsep dasar manajemen dan tata kelola TPMB, perencanaan layanan, pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi, hingga penerapan standar mutu dan pengukuran kinerja. Pembahasan juga mencakup keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, pengelolaan sarana-prasarana dan alat, manajemen obat dan bahan habis pakai, rekam medis dan kerahasiaan data, sistem rujukan dan jejaring pelayanan, manajemen keuangan, pelaporan insiden, analisis akar masalah,

tindakan korektif dan preventif, pengelolaan keluhan, serta audit mutu dan persiapan akreditasi. Cakupan tersebut disusun untuk memperkuat kemampuan pembaca dalam mengelola pelayanan kebidanan secara terintegrasi, berbasis risiko, dan berorientasi pada kebutuhan klien.

Penyusunan buku ini menggunakan pendekatan *Outcome-Based Education* atau OBE. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan konsep, tetapi juga pada kemampuan menganalisis masalah, mengambil keputusan, menyusun dokumen pelayanan, mengidentifikasi risiko, mengukur kinerja, dan merancang perbaikan yang dapat diterapkan dalam situasi nyata. Melalui studi kasus, aktivitas diskusi, simulasi, latihan soal, penugasan, serta asesmen berbasis capaian pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu menghubungkan pengetahuan teoretis dengan kebutuhan pengelolaan pelayanan kebidanan di lapangan.

Aspek mutu dan keselamatan pasien ditempatkan sebagai landasan utama dalam setiap pembahasan. Mutu pelayanan tidak hanya dinilai dari hasil klinis, tetapi juga dari kesiapan struktur, ketepatan proses pelayanan, efektivitas komunikasi, kelengkapan dokumentasi, kepuasan klien, serta kemampuan organisasi dalam belajar dari risiko dan insiden. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat membangun budaya pelayanan yang terbuka, adil, tidak saling menyalahkan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Buku ini juga menekankan bahwa tata kelola TPMB yang baik tidak cukup diwujudkan melalui ketersediaan dokumen dan standar operasional prosedur. Tata kelola harus tampak dalam pembagian peran yang jelas, kepemimpinan yang bertanggung jawab, pengelolaan sumber daya yang efisien, komunikasi yang efektif, perlindungan kerahasiaan data, kesiapan rujukan, transparansi pembiayaan, serta evaluasi

pelayanan secara berkala. Seluruh unsur tersebut merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun pelayanan kebidanan yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kontribusi dalam penyusunan buku ajar ini. Penghargaan juga disampaikan kepada para pendidik, praktisi, organisasi profesi, pengelola institusi pendidikan, serta tenaga kesehatan yang terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pengalaman dan dedikasi mereka menjadi sumber pembelajaran yang sangat berharga dalam penyusunan materi buku ini.

Akhir kata, semoga buku ajar *Manajemen Pelayanan Kebidanan: Mutu, Keselamatan Pasien, dan Tata Kelola TPMB* dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, dosen, bidan, pengelola TPMB, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap peningkatan mutu pelayanan kebidanan. Semoga buku ini turut berkontribusi dalam membentuk bidan yang profesional, berintegritas, adaptif, mampu mengambil keputusan berbasis data, serta konsisten menempatkan keselamatan dan kebutuhan klien sebagai prioritas utama.

**Agustus 2026**

Penulis

# DAFTAR ISI

**PRAKATA** ..... **iv**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**

**BAB 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN DAN TATA KELOLA TPMB** ..... **1**
A. Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Kebidanan ..... 18
B. Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) ..... 20
C. Kerangka Regulasi Pelayanan Kebidanan dan TPMB ..... 20
D. Kewenangan Praktik Bidan ..... 21
E. Prinsip Tata Kelola TPMB ..... 23
F. Kesiapan Tata Kelola TPMB ..... 23
G. Akuntabilitas dan Mutu Dasar Pelayanan TPMB ..... 25
H. Tantangan Tata Kelola TPMB ..... 26
I. Ringkasan ..... 26
J. Latihan Soal ..... 27
K. Referensi ..... 28

**BAB 2 MANAJEMEN SDM DAN KOMPETENSI: KEWENANGAN, PENJADWALAN, PELATIHAN, DAN BUDAYA PROFESIONAL** ..... **30**
A. Konsep Manajemen SDM dalam Kebidanan ..... 34
B. Kewenangan dalam Praktik Kebidanan ..... 35
C. Penjadwalan Pelatihan dalam Pengembangan Kompetensi ..... 36
D. Budaya Profesional dalam Kebidanan ..... 38

E. Integrasi Kewenangan, Pelatihan, dan Budaya Profesional .....39
F. Aktivitas 1 — *Knows How*.....39
G. Aktivitas 2 — *Shows How*.....41
H. Latihan Soal.....42
I. Referensi.....52

**BAB 3 MUTU PELAYANAN KEBIDANAN: STANDAR MUTU, INDIKATOR, DAN PENGUKURAN KINERJA ..... 54**
A. Konsep Mutu Pelayanan Kebidanan.....68
B. Standar Mutu Pelayanan Kebidanan.....69
C. Indikator Mutu Pelayanan Kebidanan.....70
D. Pengukuran Kinerja Pelayanan Kebidanan .....71
E. Implementasi Mutu Pelayanan di TPMB.....72
F. Integrasi Mutu dengan Keselamatan Pasien.....73
G. Rangkuman.....73
H. Latihan Soal.....74
I. Glosarium.....83
J. Referensi.....83

**PROFIL PENULIS ..... 84**

# BAB 1

# KONSEP DASAR MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN DAN TATA KELOLA TPMB

**CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan pelayanan kebidanan. | CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-2 | Menerapkan komunikasi efektif dan kolaborasi lintas profesi/jejaring dalam tata kelola layanan kebidanan berpusat pada klien. | CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-7 |
| CPL-3 | Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan layanan. | CPMK-5; CPMK-6; CPMK-2 |
| CPL-4 | Mengelola mutu layanan melalui standar, indikator, audit, dan perbaikan berkelanjutan berbasis data. | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-5 | Mengelola sumber daya (SDM, sarpras, alat, obat/BHP, dan keuangan) secara efisien dan akuntabel. | CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2 |
| CPL-6 | Mengelola dokumentasi, informasi, dan kerahasiaan data serta evaluasi pengalaman klien (kepuasan/keluhan). | CPMK-6; CPMK-7; CPMK-4 |

## CPMK

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menganalisis regulasi, kewenangan, dan prinsip tata kelola TPMB untuk memastikan kepatuhan, etika, dan akuntabilitas. |
| CPMK-2 | Merancang perencanaan layanan TPMB (visi–misi, paket layanan, alur pelayanan, dan SOP inti) berbasis kebutuhan klien dan risiko. |
| CPMK-3 | Menyusun sistem manajemen SDM dan pengembangan kompetensi (kewenangan, penjadwalan, pelatihan, budaya profesional) untuk mendukung kinerja tim. |
| CPMK-4 | Mengembangkan dan mengevaluasi sistem manajemen mutu (standar, indikator, pengukuran kinerja, audit, dan rencana peningkatan mutu) berbasis data. |
| CPMK-5 | Merancang dan menerapkan program keselamatan pasien dan manajemen risiko termasuk PPI, pelaporan insiden, RCA, dan CAPA. |
| CPMK-6 | Mengelola sarana-prasarana, alat, obat, BHP, rekam medis, serta keamanan informasi untuk menjamin ketersediaan, keselamatan, dan kepatuhan. |
| CPMK-7 | Mengelola jejaring rujukan, komunikasi layanan, kepuasan/keluhan klien, dan aspek keuangan dasar untuk keberlanjutan layanan. |

## Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1. Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Kebidanan dan Tata Kelola TPMB | 1.1 Menguraikan kerangka regulasi, kewenangan praktik, dan prinsip tata kelola TPMB. | 1.2 Menilai kesiapan tata kelola (struktur, kebijakan, dokumentasi, peran) untuk akuntabilitas dan mutu dasar. | CPMK-1 | CPMK-4; CPMK-5 |
| Bab 2. Perencanaan Layanan TPMB: Visi–Misi, Paket Layanan, Alur Pelayanan, dan Standar Operasional | 2.1 Merumuskan visi–misi, sasaran layanan, dan paket layanan berbasis kebutuhan klien dan risiko. | 2.2 Menyusun alur pelayanan dan SOP inti yang memuat titik kontrol keselamatan. | CPMK-2 | CPMK-1; CPMK-6 |
| Bab 3. Manajemen SDM dan Kompetensi: Kewenangan, Penjadwalan, Pelatihan, dan Budaya Profesional | 3.1 Menetapkan kewenangan/uraian tugas dan penjadwalan berbasis beban kerja dan keselamatan. | 3.2 Merancang pelatihan, supervisi, dan strategi budaya profesional (etik, teamwork, | CPMK-3 | CPMK-1; CPMK-4 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| | | disiplin mutu). | | |
| Bab 4. Mutu Pelayanan Kebidanan: Standar Mutu, Indikator, dan Pengukuran Kinerja | 4.1 Menetapkan standar mutu dan indikator prioritas beserta definisi operasionalnya. | 4.2 Melakukan pengukuran kinerja dan analisis hasil untuk rekomendasi perbaikan. | CPMK-4 | CPMK-2; CPMK-3 |
| Bab 5. Keselamatan Pasien di TPMB: Identifikasi Risiko, Pencegahan Insiden, dan Keselamatan Klinis | 5.1 Mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan pasien pada alur layanan. | 5.2 Menyusun strategi pencegahan insiden dan rencana respons kejadian. | CPMK-5 | CPMK-2; CPMK-4 |
| Bab 6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): APD, Sterilisasi, Limbah Medis, dan Sanitasi | 6.1 Memilih tindakan PPI (APD, kebersihan tangan, dekontaminasi/sterilisasi) sesuai tingkat risiko. | 6.2 Menyusun sistem pengelolaan limbah medis dan sanitasi lingkungan sesuai standar. | CPMK-5 | CPMK-6; CPMK-4 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 7. Manajemen Sarana, Prasarana, dan Alat: Kesiapan Ruang, Kalibrasi, dan Pemeliharaan | 7.1 Menilai kesiapan ruang (layout, zonasi, alur bersih–kotor) untuk keselamatan dan efisiensi. | 7.2 Menyusun rencana kalibrasi, pemeliharaan, dan pencatatan alat. | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-2 |
| Bab 8. Manajemen Obat dan Bahan Habis Pakai: Perencanaan, Penyimpanan, Logistik, dan Kedaluwarsa | 8.1 Menyusun perencanaan kebutuhan obat/BHP berbasis pola layanan, stok minimum, dan anggaran. | 8.2 Menerapkan sistem penyimpanan dan monitoring (FEFO/FIFO, kedaluwarsa, kartu stok). | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-7 |
| Bab 9. Manajemen Rekam Medis dan Kerahasiaan Data: Standar Pencatatan, Audit Trail, | 9.1 Menerapkan standar pencatatan rekam medis dan audit trail (lengkap, tepat waktu, dapat telusur). | 9.2 Merancang kontrol kerahasiaan dan keamanan informasi (akses, backup, | CPMK-6 | CPMK-1; CPMK-4 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| dan Keamanan Informasi | | respons insiden). | | |
| Bab 10. Manajemen Rujukan dan Jejaring Pelayanan: Kolaborasi, Komunikasi, dan Transport Aman | 10.1 Menyusun prosedur rujukan aman (kriteria, stabilisasi awal, komunikasi, dokumentasi). | 10.2 Membangun jejaring kolaborasi dan mekanisme umpan balik rujukan. | CPMK-7 | CPMK-2; CPMK-5 |
| Bab 11. Manajemen Keuangan TPMB: Tarif, Pembukuan, Pengendalian Biaya, dan Pelaporan | 11.1 Menyusun struktur tarif dan paket pembayaran yang transparan dan konsisten. | 11.2 Menerapkan pembukuan, pengendalian biaya, dan pelaporan untuk keputusan manajerial. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-1 |
| Bab 12. Manajemen Risiko dan Pelaporan Insiden: RCA, CAPA, dan Perbaikan Berkelanjutan | 12.1 Mengoperasionalkan pelaporan insiden secara non-punitif, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. | 12.2 Melakukan RCA dan menetapkan CAPA serta monitoring efektivitas. | CPMK-5 | CPMK-4; CPMK-1 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 13. Kepuasan Klien dan Pengelolaan Keluhan: Survei, Umpan Balik, dan Service Recovery | 13.1 Merancang survei kepuasan dan kanal umpan balik dengan indikator layanan yang relevan. | 13.2 Menyusun mekanisme penanganan keluhan dan service recovery berbasis SLA dan dokumentasi. | CPMK-7 | CPMK-4; CPMK-2 |
| Bab 14. Audit Mutu dan Akreditasi: Persiapan Dokumen, Simulasi Penilaian, dan Rencana Peningkatan Mutu | 14.1 Menyusun rencana audit mutu internal dan kesiapan dokumen akreditasi. | 14.2 Melaksanakan simulasi penilaian, analisis gap, dan rencana peningkatan mutu. | CPMK-4 | CPMK-1; CPMK-7 |

**Asesmen (berbasis CPMK)**

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-1 | Tes tertulis berbasis kasus; analisis dokumen | Ketepatan identifikasi regulasi/kewenangan; rekomendasi kontrol kepatuhan dan akuntabilitas yang operasional | 10 | Lembar jawaban studi kasus; ringkasan analisis kepatuhan |
| CPMK-2 | Proyek perencanaan layanan; penilaian dokumen SOP | Visi–misi dan sasaran terukur; alur layanan lengkap; SOP memuat langkah, penanggung jawab, dan titik kontrol keselamatan | 15 | Dokumen rencana layanan; flowchart alur; SOP inti |
| CPMK-3 | Proyek manajemen SDM; studi kasus penjadwalan | Pemetaan kewenangan/uraian tugas jelas; jadwal memenuhi kebutuhan layanan; rencana pelatihan berbasis gap; strategi budaya profesional terukur | 10 | Dokumen SDM (credentialing, jadwal); rencana pelatihan/supervisi |
| CPMK-4 | Tugas dashboard indikator; audit mini; presentasi | Definisi operasional indikator jelas; perhitungan indikator akurat; analisis temuan berbasis data; rencana perbaikan dengan target, PIC, dan waktu | 20 | Dashboard indikator; laporan audit; rencana PDSA/RPM |
| CPMK-5 | Simulasi tabletop | Identifikasi risiko pada skenario; rancangan | 20 | Checklist risiko; formulir |

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| | keselamatan; workshop RCA/CAPA | mitigasi sesuai prioritas; pelaporan insiden lengkap; RCA logis; CAPA SMART dan ada monitoring | | insiden; laporan RCA & CAPA |
| CPMK-6 | Praktik penyusunan logbook; audit kepatuhan dokumentasi | Inventaris/kalibrasi/pemeliharaan lengkap; logistik obat/BHP menerapkan FEFO dan stok minimum; kelengkapan pencatatan; kontrol akses/backup terdokumentasi | 15 | Logbook alat; kartu stok; contoh rekam medis; SOP keamanan informasi |
| CPMK-7 | Studi kasus rujukan & komunikasi; tugas keuangan; survei layanan | Kriteria & alur rujukan aman; komunikasi terstruktur (mis. SBAR) dan dokumentasi rujukan; tarif/pembukuan konsisten; instrumen kepuasan & alur keluhan dengan SLA | 10 | SOP rujukan + contoh komunikasi; template pembukuan; instrumen survei & alur keluhan |

## Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-1

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Ketepatan identifikasi regulasi/kewenangan dan risiko kepatuhan | Banyak tidak tepat/tidak relevan; risiko kepatuhan tidak teridentifikasi | Sebagian tepat; masih ada kekeliruan/kelalaian penting | Hampir seluruhnya tepat; hanya kekurangan minor | Lengkap dan akurat; risiko kepatuhan terpetakan jelas dan relevan |
| 1.2 Kualitas rekomendasi tata kelola (kebijakan, peran, dokumentasi, kontrol) | Rekomendasi umum/tidak operasional; tanpa kontrol | Ada rekomendasi, tetapi belum prioritatif/kurang operasional | Rekomendasi operasional, prioritas cukup jelas, kontrol memadai | Rekomendasi sangat operasional, prioritas berbasis risiko, kontrol dan monitoring jelas |

Rubrik CPMK-2

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Kejelasan visi–misi, sasaran, dan paket layanan | Tidak konsisten; sasaran tidak terukur; paket layanan tidak sesuai kebutuhan | Cukup konsisten; sasaran sebagian terukur; paket layanan masih kurang lengkap | Konsisten; sasaran terukur; paket layanan sesuai kebutuhan utama | Sangat konsisten; sasaran SMART; paket layanan komprehensif dan berbasis kebutuhan/risiko |
| 2.2 Kelengkapan alur layanan dan SOP inti dengan kontrol keselamatan | Alur tidak lengkap; SOP tidak jelas; kontrol keselamatan tidak ada | Alur cukup; SOP ada namun langkah/PIC kurang jelas; kontrol terbatas | Alur lengkap; SOP jelas (langkah, PIC, dokumen); kontrol keselamatan memadai | Alur sangat rapi; SOP sangat operasional; kontrol keselamatan kritis terintegrasi dan mudah diaudit |

Rubrik CPMK-3

| **Indikator** | **Skor 1 (Kurang)** | **Skor 2 (Cukup)** | **Skor 3 (Baik)** | **Skor 4 (Sangat Baik)** |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Ketepatan kewenangan/uraian tugas dan penjadwalan | Kewenangan tidak jelas; jadwal tidak realistis/abaikan keselamatan | Kewenangan cukup; jadwal berjalan tetapi belum | Kewenangan jelas; jadwal berbasis beban kerja dan | Kewenangan sangat jelas (termasuk mekanisme |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| | | berbasis beban kerja | kontinuitas layanan | delegasi); jadwal optimal dan mitigasi risiko kelelahan |
| 3.2 Desain pengembangan kompetensi dan budaya profesional | Tidak berbasis kebutuhan; tanpa mekanisme supervisi | Ada pelatihan, tetapi belum berbasis gap; budaya profesional belum terukur | Pelatihan berbasis gap; supervisi terencana; intervensi budaya profesional jelas | Pelatihan berjenjang; supervisi & evaluasi kuat; budaya profesional dibangun dengan indikator dan tindak lanjut |

Rubrik CPMK-4

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Perumusan indikator mutu dan pengolahan data | Indikator tidak jelas; definisi operasional tidak ada; data tidak valid | Indikator ada namun definisi operasional kurang; pengolaha | Indikator prioritas jelas; definisi operasional lengkap; | Indikator sangat tepat; data tervalidasi; analitik (tren/segmentasi) memperkuat keputusan |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| | | n data terbatas | perhitunga n akurat | |
| 4.2 Analisis temuan dan rencana peningkata n mutu | Tidak ada analisis; rencana perbaikan tidak spesifik | Analisis dasar; rencana perbaikan belum SMART | Analisis berbasis data; rencana perbaikan SMART dengan PIC & waktu | Analisis mendalam (akar masalah); rencana perbaikan terukur, berprioritas, serta rencana evaluasi efektivitas jelas |

Rubrik CPMK-5

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Identifikasi risiko dan desain mitigasi keselamatan/P PI | Risiko tidak terpetakan; mitigasi tidak sesuai/umu m | Risiko teridentifika si sebagian; mitigasi ada tetapi tidak prioritatif | Risiko terpetaka n; mitigasi sesuai prioritas dan alur kerja | Risiko terpetakan komprehensi f; mitigasi kuat (hierarki kontrol) dan ada indikator pemantauan |
| 5.2 Kualitas pelaporan insiden serta RCA dan CAPA | Laporan tidak lengkap; RCA/CAPA tidak logis | Laporan cukup; RCA masih dangkal; CAPA belum SMART | Laporan lengkap; RCA logis; CAPA SMART dengan | Laporan sangat lengkap dan tepat waktu; RCA tajam; CAPA terukur, |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| | | | monitoring | feasible, dan mekanisme evaluasi efektivitas jelas |

Rubrik CPMK-6

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Manajemen sarpras/alat/obat-BHP (ketersediaan, pemeliharaan, logistik) | Inventaris/logistik tidak rapi; tidak ada jadwal pemeliharaan; stok sering tidak terkendali | Ada inventaris dan logistik, namun belum konsisten; pemeliharaan belum terjadwal baik | Inventaris lengkap; pemeliharaan/kalibrasi terjadwal; FEFO/FIFO dan stok minimum berjalan | Sistem sangat tertata; pemeliharaan proaktif; kontrol stok kuat (early warning) dan terdokumentasi |
| 6.2 Dokumentasi rekam medis dan keamanan informasi | Pencatatan tidak lengkap; akses data tidak terkontrol; tidak ada backup | Pencatatan cukup; kontrol akses dasar; backup belum rutin | Pencatatan lengkap dan dapat telusur; kontrol akses jelas; backup rutin | Pencatatan sangat konsisten; audit trail kuat; keamanan informasi komprehensif |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | termasuk respons insiden |

Rubrik CPMK-7

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Manajemen rujukan & jejaring (komunikasi, transport aman, umpan balik) | Kriteria/alur rujukan tidak jelas; komunikasi tidak terstruktur; umpan balik tidak ada | Alur rujukan ada; komunikasi cukup; umpan balik belum konsisten | Rujukan aman (kriteria, stabilisasi, dokumen); komunikasi terstruktur; umpan balik berjalan | Rujukan sangat siap dan teruji; komunikasi sangat efektif; jejaring aktif dengan mekanisme evaluasi jejaring |
| 7.2 Keuangan dasar & pengalaman klien (kepuasan/keluhan /service recovery) | Tarif/pembukuan tidak konsisten; survei/keluhan tidak dikelola | Tarif/pembukuan dasar ada; survei/keluhan ada tetapi tanpa SLA jelas | Tarif transparan; pembukuan rapi; survei dan keluhan | Keuangan informatif untuk keputusan; survei bermakna; service recovery |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| | | | dikelola dengan SLA & dokumentasi | efektif dan menjadi input perbaikan mutu berkelanjutan |

## Uraian Materi

Pelayanan kebidanan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan perempuan, ibu, bayi baru lahir, anak, serta kesehatan reproduksi. Dalam pelaksanaannya, bidan memiliki peran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Perkembangan pelayanan kesehatan di Indonesia menuntut pelayanan kebidanan yang profesional, aman, bermutu, dan akuntabel. Salah satu bentuk pelayanan kebidanan yang berkembang di masyarakat adalah Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB). TPMB merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dikelola secara mandiri oleh bidan dengan tetap mengacu pada regulasi, standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi.

Pengelolaan TPMB tidak hanya berorientasi pada pelayanan klinis, tetapi juga mencakup aspek manajerial dan tata kelola. Tata kelola yang baik menjadi fondasi penting dalam menjamin mutu pelayanan, keselamatan pasien, efektivitas organisasi, serta kepatuhan terhadap regulasi kesehatan.

Dalam konteks *Outcome Based Education* (OBE), mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori manajemen pelayanan kebidanan, tetapi juga mampu menganalisis penerapan tata kelola TPMB secara nyata sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan modern.

## A. Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Manajemen

   Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

   Menurut George R. Terry, manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan (*planning),* pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

   Dalam pelayanan kesehatan, manajemen bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia, sarana, prasarana, metode, dan pembiayaan agar pelayanan berjalan efektif, aman, dan bermutu.

2. Pengertian Manajemen Pelayanan Kebidanan

   Manajemen pelayanan kebidanan adalah proses pengelolaan pelayanan kebidanan secara sistematis melalui fungsi manajemen untuk mencapai pelayanan yang profesional, aman, bermutu, dan berpusat pada pasien.

   Pelayanan kebidanan mencakup:

   a. Pelayanan kesehatan ibu
   b. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan
   c. Pelayanan keluarga berencana
   d. Pelayanan neonatal dan bayi
   e. Pelayanan kesehatan anak
   f. Pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal sesuai kewenangan

   Manajemen pelayanan kebidanan berfungsi untuk:

   a. Meningkatkan mutu pelayanan
   b. Menjamin keselamatan pasien

c. Mengoptimalkan sumber daya
d. Meningkatkan kepuasan pasien
e. Menjamin kepatuhan terhadap standar profesi

3. Fungsi Manajemen dalam Pelayanan Kebidanan
   a. Perencanaan (Planning)
      Perencanaan merupakan proses menetapkan tujuan dan langkah-langkah pelayanan.
      Contoh:
      1) Menentukan jenis pelayanan TPMB
      2) Menyusun kebutuhan alat kesehatan
      3) Menyusun jadwal pelayanan
      4) Menentukan kebutuhan tenaga
   b. Pengorganisasian (Organizing)
      Pengorganisasian adalah pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan.
      Contoh:
      1) Pembagian tugas bidan
      2) Penetapan alur pelayanan
      3) Penetapan struktur organisasi TPMB
   c. cPelaksanaan (Actuating)
      Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan pelayanan sesuai rencana.
      Contoh:
      1) Pelayanan antenatal care
      2) Persalinan normal
      3) Konseling KB
      4) Dokumentasi pelayanan
   d. Pengawasan (Controlling)
      Pengawasan bertujuan memastikan pelayanan sesuai standar.
      Contoh:

1) Audit rekam medis
2) Monitoring kepatuhan SOP
3) Evaluasi kepuasan pasien
4) Penilaian mutu pelayanan

## B. Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB)

1. Pengertian TPMB

   TPMB adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan secara mandiri sesuai kewenangan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. TPMB menjadi sarana pelayanan kesehatan dasar yang dekat dengan masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2. Tujuan TPMB

   Tujuan penyelenggaraan TPMB antara lain:

   a. Meningkatkan akses pelayanan kebidanan
   b. Memberikan pelayanan yang aman dan bermutu
   c. Mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi
   d. Memberikan pelayanan berkesinambungan
   e. Meningkatkan kemandirian profesi bidan

3. Karakteristik TPMB

   Karakteristik TPMB meliputi:

   a. Dikelola oleh bidan
   b. Memiliki izin praktik
   c. Memberikan pelayanan sesuai kompetensi
   d. Mengutamakan keselamatan pasien
   e. Memiliki sistem dokumentasi pelayanan
   f. Memiliki standar operasional prosedur (SOP)

## C. Kerangka Regulasi Pelayanan Kebidanan dan TPMB

1. Pengertian Regulasi

Regulasi adalah seperangkat aturan yang mengatur penyelenggaraan praktik pelayanan kesehatan agar berjalan sesuai standar hukum dan etika profesi.

2. Dasar Hukum Praktik Kebidanan
   Praktik kebidanan di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
      Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan kesehatan nasional termasuk praktik tenaga kesehatan.
   b. Undang-Undang Kebidanan
      Mengatur:
      1) Profesi bidan
      2) Pendidikan kebidanan
      3) Registrasi dan izin praktik
      4) Hak dan kewajiban bidan
      5) Perlindungan hukum bidan
   c. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Praktik Bidan
      Mengatur:
      1) Standar pelayanan
      2) Kewenangan bidan
      3) Persyaratan praktik mandiri
      4) Keselamatan pasien
      5) Dokumentasi pelayanan
   d. Kode Etik Profesi Bidan
      Kode etik menjadi pedoman moral dan profesional dalam memberikan pelayanan kebidanan.

## D. Kewenangan Praktik Bidan

1. Pengertian Kewenangan Praktik

Kewenangan praktik adalah hak yang diberikan kepada bidan untuk melaksanakan pelayanan sesuai kompetensi, pendidikan, dan regulasi yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Kewenangan Bidan
   Kewenangan bidan mencakup:
   a. Pelayanan Kesehatan Ibu
      1) Antenatal care
      2) Persalinan normal
      3) Asuhan nifas
      4) Deteksi komplikasi
   b. Pelayanan Neonatal dan Bayi
      1) Perawatan bayi baru lahir
      2) Resusitasi dasar neonatal
      3) Pemantauan tumbuh kembang
   c. Pelayanan Kesehatan Reproduksi
      1) Konseling kesehatan reproduksi
      2) Pelayanan KB
   d. Pelayanan Kegawatdaruratan
      1) Penanganan awal kegawatdaruratan maternal neonatal
      2) Rujukan tepat waktu
3. Batasan Kewenangan Bidan
   Bidan wajib:
   a. Bekerja sesuai kompetensi
   b. Melakukan rujukan bila ditemukan komplikasi
   c. Mematuhi SOP
   d. Menjaga keselamatan pasien

   Pelanggaran kewenangan dapat berdampak pada:
   a. Sanksi administratif
   b. Sanksi etik

c. Sanksi hukum

## E. Prinsip Tata Kelola TPMB

1. Pengertian Tata Kelola

   Tata kelola (*governance*) adalah sistem pengelolaan organisasi yang mengatur hubungan fungsi, proses, tanggung jawab, dan pengawasan agar pelayanan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

2. Prinsip-Prinsip Tata Kelola TPMB

   a. Akuntabilitas
      TPMB harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh pelayanan yang diberikan.
      Contoh:
      1) Rekam medis lengkap
      2) Pelaporan pelayanan
      3) Dokumentasi Tindakan

   b. Transparansi
      Informasi pelayanan harus jelas dan terbuka.
      Contoh:
      1) Tarif pelayanan
      2) Jam praktik
      3) Jenis pelayanan

   c. Responsibilitas
      TPMB wajib mematuhi regulasi dan standar profesi.

   d. Independensi
      Pelayanan dilakukan secara profesional tanpa konflik kepentingan.

   e. Keadilan
      Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi**.**

## F. Kesiapan Tata Kelola TPMB

1. Struktur Organisasi TPMB

Struktur organisasi membantu pembagian tugas dan tanggung jawab.

Contoh struktur sederhana TPMB:

a. Penanggung jawab TPMB
b. Bidan pelaksana
c. Administrasi
d. Petugas kebersihan

Struktur organisasi yang jelas meningkatkan efektivitas pelayanan.

2. Kebijakan dan SOP

TPMB harus memiliki kebijakan tertulis dan SOP untuk menjamin standar pelayanan.

Contoh SOP:

a. SOP ANC
b. SOP persalinan normal
c. SOP rujukan
d. SOP pengendalian infeksi
e. SOP kegawatdaruratan

3. Dokumentasi Pelayanan

Dokumentasi merupakan bukti pelayanan dan alat perlindungan hukum.

Dokumen penting:

a. Rekam medis
*b. Informed consent*
c. Buku register
d. Laporan rujukan
e. Pelaporan kegiatan

Dokumentasi harus:

a. Lengkap
b. Akurat

c. Tepat waktu
d. Rahasia

4. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
   Pembagian tugas penting untuk mencegah tumpang tindih pekerjaan.
   Contoh:
   a. Bidan penanggung jawab mengelola pelayanan
   b. Petugas administrasi mengelola pendaftaran
   c. Asisten membantu persiapan alat

## G. Akuntabilitas dan Mutu Dasar Pelayanan TPMB

1. Akuntabilitas Pelayanan
   Akuntabilitas adalah kemampuan mempertanggungjawabkan pelayanan kepada pasien, organisasi profesi, dan pemerintah.
   Indikator akuntabilitas:
   a. Kepatuhan SOP
   b. Kelengkapan dokumentasi
   c. Kepatuhan regulasi
   d. Pelaporan rutin
2. Mutu Pelayanan Dasar
   Mutu pelayanan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pasien sesuai standar profesi.
   Dimensi mutu:
   a. Keselamatan
   b. Efektivitas
   c. Efisiensi
   d. Ketepatan waktu
   e. Berpusat pada pasien
3. Upaya Peningkatan Mutu
   Upaya peningkatan mutu dapat dilakukan melalui:

a. Pelatihan berkala
b. Audit internal
c. Evaluasi kepuasan pasien
d. Monitoring indikator mutu
e. Peningkatan kompetensi SDM

## H. Tantangan Tata Kelola TPMB

Beberapa tantangan dalam tata kelola TPMB:

1. Keterbatasan sumber daya
2. Dokumentasi belum optimal
3. Kepatuhan SOP yang belum konsisten
4. Keterbatasan sarana prasarana
5. Perubahan regulasi kesehatan

Solusi yang dapat dilakukan:

1. Penguatan pelatihan manajemen
2. Digitalisasi dokumentasi
3. Pendampingan mutu
4. Penguatan supervisi
5. Kolaborasi lintas profesi

## I. Ringkasan

Manajemen pelayanan kebidanan merupakan proses pengelolaan pelayanan kebidanan secara sistematis untuk mencapai pelayanan yang profesional, aman, dan bermutu. TPMB sebagai fasilitas pelayanan kesehatan mandiri harus dikelola berdasarkan regulasi, standar profesi, dan prinsip tata kelola yang baik.

Kesiapan tata kelola TPMB meliputi struktur organisasi, kebijakan, SOP, dokumentasi, dan pembagian peran yang jelas. Tata kelola yang baik akan meningkatkan akuntabilitas,

mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kebidanan.

## J. Latihan Soal

Pilihan Ganda

1. Fungsi manajemen yang berkaitan dengan penyusunan tujuan pelayanan disebut ...
   A. Controlling
   B. Planning
   C. Actuating
   D. Evaluating

2. Salah satu prinsip tata kelola TPMB adalah …
   A. Diskriminasi
   B. Transparansi
   C. Kompetisi bebas
   D. Sentralisasi

3. Dokumen yang menjadi bukti pelayanan kebidanan adalah …
   A. SOP
   B. Struktur organisasi
   C. Rekam medis
   D. Jadwal praktik

Essay
1. Jelaskan pengertian manajemen pelayanan kebidanan!
2. Uraikan prinsip-prinsip tata kelola TPMB!
3. Jelaskan pentingnya dokumentasi dalam pelayanan kebidanan!

## K. Referensi


Ikatan Bidan Indonesia. (n.d.). *Standar profesi bidan Indonesia*. IBI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Pedoman penyelenggaraan praktik mandiri bidan*. Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (n.d.). *Standar pelayanan kebidanan*. Kementerian Kesehatan RI.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (n.d.). *Leadership roles and management functions in nursing*. Lippincott Williams & Wilkins.

Notoatmodjo, S. (n.d.). *Manajemen kesehatan*. Rineka Cipta.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*.

Terry, G. R. (n.d.). *Principles of management*. Richard D. Irwin

.

# BAB 2

# MANAJEMEN SDM DAN KOMPETENSI: KEWENANGAN, PENJADWALAN, PELATIHAN, DAN BUDAYA PROFESIONAL

**CPL**

| No | Kode | Ranah | Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|---|---|
| 1 | **CPL-S1** | Sikap | Mampu menunjukkan sikap profesional, berintegritas, bertanggung jawab, berempati, menghormati kode etik profesi, serta mengutamakan keselamatan ibu dan bayi dalam pelayanan kebidanan. |
| 2 | **CPL-P1** | Pengetahuan | Mampu menguasai konsep dan prinsip manajemen sumber daya manusia dalam pelayanan kebidanan, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, kewenangan bidan, pengembangan kompetensi, dan budaya profesional. |
| 3 | **CPL-KU1** | Keterampilan Umum | Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menganalisis permasalahan serta mengambil keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia kebidanan. |
| 4 | **CPL-KK1** | Keterampilan Khusus | Mampu merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan |

| No | Kode | Ranah | Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan |
|---|---|---|---|
| | | | mengevaluasi pengelolaan tenaga kebidanan berbasis kompetensi untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. |
| 5 | **CPL-KK2** | Keterampilan Khusus | Mampu memberikan asuhan, melakukan komunikasi profesional, mengambil keputusan klinis, berkolaborasi, dan melaksanakan rujukan sesuai kompetensi, kewenangan, standar prosedur operasional, serta kondisi fasilitas pelayanan kesehatan. |

**(CPMK)**

| No. | Kode | Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Ranah/Level |
|---|---|---|---|
| 1 | **CPMK-1** | Mahasiswa mampu **menjelaskan** konsep, tujuan, fungsi, dan ruang lingkup manajemen sumber daya manusia dalam pelayanan kebidanan. | Kognitif – **C2** |
| 2 | **CPMK-2** | Mahasiswa mampu **menganalisis** dasar, ruang lingkup, prinsip, permasalahan, dan strategi penerapan kewenangan bidan berdasarkan kompetensi, standar prosedur operasional, keselamatan pasien, serta tanggung jawab hukum. | Kognitif – **C4** |
| 3 | **CPMK-3** | Mahasiswa mampu **merancang** program dan jadwal pelatihan tenaga kebidanan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan, prioritas | Kognitif – **C6** |

| No. | Kode | Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Ranah/Level |
|---|---|---|---|
| | | kompetensi, ketersediaan tenaga, dan kesinambungan pelayanan. | |
| 4 | **CPMK-4** | Mahasiswa mampu **mengevaluasi** pelaksanaan dan efektivitas pelatihan tenaga kebidanan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, penilaian kinerja, umpan balik, simulasi, serta OSCE berdasarkan Piramida Miller. | Kognitif – **C5**; Psikomotor – **P3** |
| 5 | **CPMK-5** | Mahasiswa mampu **menilai** penerapan nilai integritas, tanggung jawab, empati, kerja sama tim, komunikasi profesional, akuntabilitas, dan budaya keselamatan dalam pelayanan kebidanan. | Kognitif – **C5**; Afektif – **A4** |
| 6 | **CPMK-6** | Mahasiswa mampu **menganalisis** masalah klinis dan menentukan tindakan, kolaborasi, atau rujukan berdasarkan kondisi ibu dan janin, kewenangan bidan, kompetensi tenaga, fasilitas pelayanan, dan prinsip keselamatan pasien. | Kognitif – **C4–C5** |
| 7 | **CPMK-7** | Mahasiswa mampu **mendemonstrasikan** pengambilan keputusan klinis, komunikasi efektif, pemberian informed consent, koordinasi tim, pemantauan kondisi ibu dan janin, persiapan rujukan, serta tindakan keselamatan pasien dalam simulasi kasus kebidanan. | Psikomotor – **P4**; Afektif – **A4** |
| 8 | **CPMK-8** | Mahasiswa mampu **menyusun** program perbaikan manajemen sumber | Kognitif – **C6**; Afektif – **A5** |

| No. | Kode | Rumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah | Ranah/Level |
|---|---|---|---|
| | | daya manusia kebidanan yang mengintegrasikan pemetaan kompetensi, kejelasan kewenangan, penjadwalan pelatihan, supervisi klinis, audit praktik, komunikasi profesional, dan budaya keselamatan. | |

## Uraian Materi

Manajemen sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan, termasuk dalam praktik kebidanan. Kualitas pelayanan kebidanan sangat ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap profesional, serta kemampuan dalam pengambilan keputusan klinis. Dalam konteks pelayanan kesehatan modern, bidan tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan masyarakat.

Manajemen SDM dalam kebidanan berfokus pada pengelolaan tenaga bidan secara sistematis, mulai dari perencanaan, pengembangan kompetensi, pengaturan kewenangan, hingga pembentukan budaya profesional. Ketiga aspek utama yang akan dibahas dalam bab ini adalah kewenangan bidan, penjadwalan pelatihan, serta budaya profesional.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan erat. Kewenangan menentukan batas praktik bidan, pelatihan meningkatkan kompetensi, dan budaya profesional menjadi landasan etika serta perilaku dalam pelayanan. Tanpa pengelolaan yang baik, ketiga aspek ini dapat menimbulkan risiko terhadap mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

### A. Konsep Manajemen SDM dalam Kebidanan

Manajemen SDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam pelayanan kebidanan, manajemen SDM bertujuan untuk memastikan bahwa setiap bidan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar praktik.

1. Tujuan Manajemen SDM
   a. Meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan
   b. Menjamin keselamatan ibu dan bayi
   c. Mengoptimalkan kinerja tenaga bidan
   d. Meningkatkan kepuasan pasien
   e. Mengembangkan profesionalisme tenaga kesehatan
2. Fungsi Manajemen SDM
   a. Perencanaan SDM: Menentukan kebutuhan tenaga bidan
   b. Pengorganisasian: Penempatan sesuai kompetensi
   c. Pengarahan: Pembinaan dan supervisi
   d. Pengendalian: Evaluasi kinerja dan mutu pelayanan

**B. Kewenangan dalam Praktik Kebidanan**

1. Pengertian Kewenangan

   Kewenangan adalah hak dan tanggung jawab yang diberikan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kompetensi dan peraturan perundang-undangan. Dalam kebidanan, kewenangan menjadi batas legal praktik yang harus dipatuhi oleh bidan.
2. Dasar Hukum Kewenangan Bidan

   Kewenangan bidan di Indonesia diatur dalam:
   a. Undang-Undang Tenaga Kesehatan
   b. Peraturan Menteri Kesehatan
   c. Standar Profesi Bidan
   d. Kode Etik Profesi

   Kewenangan ini mencakup pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, kesehatan reproduksi, serta pelayanan keluarga berencana.
3. Ruang Lingkup Kewenangan Bidan

a. Pelayanan Kehamilan (ANC)
b. Persalinan Normal
c. Pelayanan Nifas dan Neonatal
d. Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi
e. Deteksi Dini Komplikasi

4. Prinsip Kewenangan
   a. Berdasarkan kompetensi
   b. Mengutamakan keselamatan pasien
   c. Dilakukan sesuai standar prosedur operasional (SPO)
   d. Memiliki tanggung jawab hukum
5. Masalah dalam Implementasi Kewenangan
   Beberapa tantangan:
   a. Overlapping kewenangan dengan tenaga kesehatan lain
   b. Kurangnya pemahaman regulasi
   c. Keterbatasan fasilitas
   d. Tekanan situasi darurat
6. Solusi dan Strategi
   a. Sosialisasi regulasi secara berkala
   b. Pelatihan berbasis kompetensi
   c. Supervisi klinis
   d. Audit praktik kebidanan

## C. Penjadwalan Pelatihan dalam Pengembangan Kompetensi

1. Pentingnya Pelatihan

   Pelatihan merupakan upaya sistematis untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan. Dalam kebidanan, pelatihan sangat penting karena ilmu terus berkembang dan standar pelayanan selalu diperbarui.

2. Tujuan Pelatihan

a. Meningkatkan keterampilan klinis
b. Memperbarui pengetahuan
c. Meningkatkan kualitas pelayanan
d. Mengurangi kesalahan medis

3. Jenis Pelatihan Kebidanan
   a. Pelatihan Teknis
      1) Asuhan persalinan normal
      2) Penanganan kegawatdaruratan maternal neonatal
   b. Pelatihan Non-Teknis
      1) Komunikasi efektif
      2) Etika profesi
      3) Manajemen stres
   c. Pelatihan Berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD)
4. Prinsip Penjadwalan Pelatihan
   a. Berbasis kebutuhan (Training Need Analysis)
   b. Terencana dan sistematis
   c. Berkesinambungan
   d. Tidak mengganggu pelayanan
5. Model Penjadwalan Pelatihan
   a. Rotasi Pelatihan
      Tenaga mengikuti pelatihan secara bergantian
   b. Blended Learning
      Kombinasi online dan offline
   c. On-the-Job Training
      Pelatihan langsung di tempat kerja
   d. Workshop Berkala
6. Evaluasi Pelatihan
   Evaluasi dilakukan melalui:
   a. Pre-test dan post-test

b. Observasi praktik
c. Penilaian kinerja
d. Umpan balik peserta

## D. Budaya Profesional dalam Kebidanan

1. Pengertian Budaya Profesional

   Budaya profesional adalah nilai, norma, sikap, dan perilaku yang mencerminkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Budaya ini menjadi identitas dan standar moral dalam pelayanan kesehatan.

2. Nilai-Nilai Budaya Profesional
   a. Integritas
   b. Tanggung jawab
   c. Empati
   d. Komitmen terhadap mutu
   e. Kerja sama tim
3. Karakteristik Bidan Profesional
   a. Memiliki kompetensi tinggi
   b. Berpegang pada kode etik
   c. Mampu bekerja dalam tim
   d. Berorientasi pada pasien
   e. Selalu mengembangkan diri
4. Peran Budaya Profesional dalam Pelayanan
   Budaya profesional berperan dalam:
   a. Meningkatkan mutu pelayanan
   b. Meningkatkan kepercayaan pasien
   c. Mengurangi konflik kerja
   d. Mendukung keselamatan pasien
5. Tantangan Budaya Profesional
   a. Beban kerja tinggi
   b. Kurangnya motivasi

c. Lingkungan kerja yang tidak kondusif
d. Kurangnya penghargaan

6. Strategi Penguatan Budaya Profesional
   a. Pelatihan etika profesi
   b. Role model dari pimpinan
   c. Reward and punishment
   d. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan

## E. Integrasi Kewenangan, Pelatihan, dan Budaya Profesional

Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan. Kewenangan tanpa kompetensi akan berisiko, pelatihan tanpa budaya profesional akan kurang efektif, dan budaya profesional tanpa dasar kewenangan akan kehilangan arah.

Integrasi dilakukan melalui:

1. Sistem manajemen SDM berbasis kompetensi
2. Monitoring dan evaluasi berkala
3. Penguatan regulasi internal
4. Pengembangan kepemimpinan klinis

## F. Aktivitas 1 — *Knows How*

1. Seorang ibu, usia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan mulas sejak 5 jam yang lalu. Ibu mengatakan air ketuban belum pecah. Gerakan janin masih dirasakan.
   Hasil pemeriksaan:
   a. TD: 110/70 mmHg
   b. Nadi: 88 x/menit
   c. DJJ: 140 x/menit
   d. TFU sesuai usia kehamilan
   e. His: 3x/10 menit, durasi 40 detik

f. VT: pembukaan 6 cm, ketuban utuh
g. Presentasi janin: bokong (sungsang)

Puskesmas memiliki fasilitas dasar, namun tidak ada dokter jaga saat itu. Jarak ke rumah sakit rujukan ±45 menit.

Tugas Mahasiswa (Diskusi Kelompok):

1. Identifikasi Masalah Klinis
   a. Jenis presentasi janin
   b. Tahap persalinan
   c. Faktor risiko pada ibu dan janin
   d. Kewenangan bidan dalam kasus ini
2. Analisis Situasi
   a. Apakah persalinan dapat ditolong di puskesmas?
   b. Indikasi rujukan pada kasus ini
   c. Risiko jika persalinan dilanjutkan di tempat
3. Perencanaan Asuhan
   a. Langkah awal yang harus dilakukan bidan
   b. Persiapan rujukan (jika diperlukan)
   c. Edukasi kepada ibu dan keluarga
4. Pertimbangan Keselamatan
   a. Prinsip patient safety
   b. Pencegahan komplikasi persalinan sungsang

Output yang Diharapkan

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan alasan klinis (clinical reasoning)
2. Menentukan keputusan berbasis kewenangan
3. Mengintegrasikan pengetahuan + analisis kasus

## G. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II
Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan
Catatan untuk penulis:

1. Tidak loncat ke ujian
2. Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

| Level Miller | Metode |
|---|---|
| Knows / Knows How | Self-check + analisis mini-case |
| Shows How | OSCE Asuhan Kala II |

Catatan untuk penulis:
Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

Judul Kegiatan:
Simulasi Penatalaksanaan Persalinan Sungsang (Breech Delivery) di Puskesmas

Deskripsi Simulasi:

Mahasiswa melakukan simulasi sebagai bidan yang menghadapi persalinan sungsang pada kala II di puskesmas dengan kondisi keterbatasan fasilitas.

Fokus Keterampilan:

1. Urutan Tindakan Klinis
   a. Persiapan alat dan lingkungan
   b. Teknik pertolongan persalinan sungsang (misalnya teknik Bracht)
   c. Penanganan kepala terakhir

d. Pencegahan komplikasi

2. Komunikasi Efektif
   a. Informed consent sederhana
   b. Edukasi kepada ibu
   c. Koordinasi dengan tim / rujukan
3. Keselamatan Pasien
   a. Pencegahan asfiksia bayi
   b. Monitoring DJJ
   c. Antisipasi kegawatdaruratan

## H. Latihan Soal

1. Seorang perempuan berusia 28 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu datang ke puskesmas karena mulas sejak 5 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 88 kali/menit, DJJ 140 kali/menit, his 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik, pembukaan serviks 6 cm, ketuban utuh, dan presentasi bokong. Ibu belum mempunyai dorongan meneran dan kemajuan persalinan tidak berlangsung cepat. Puskesmas hanya memiliki fasilitas dasar, tidak terdapat dokter jaga, sedangkan rumah sakit rujukan berjarak sekitar 45 menit dan transportasi tersedia.
   Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut?
   A. Menunggu hingga pembukaan lengkap karena kondisi ibu dan janin masih stabil
   B. Melakukan amniotomi agar persalinan berlangsung lebih cepat sebelum dirujuk
   C. Menolong persalinan sungsang di puskesmas karena ibu sudah pernah melahirkan

D. Melakukan stabilisasi awal, menjelaskan kondisi kepada keluarga, menghubungi rumah sakit, dan segera menyiapkan rujukan
E. Mencoba mengubah presentasi bokong menjadi kepala secara manual selama persalinan aktif

2. Koordinator ruang bersalin melakukan evaluasi pelayanan selama tiga bulan terakhir. Hasil evaluasi menunjukkan terdapat dua kejadian hampir cedera karena bidan kurang terampil mengenali kegawatdaruratan maternal dan empat dokumentasi rujukan tidak lengkap. Ruang bersalin memiliki 15 bidan yang bekerja dalam tiga sif. Pelayanan harus tetap berjalan selama 24 jam dan hanya tiga bidan dari setiap kelompok yang dapat meninggalkan pelayanan secara bergantian. Anggaran pelatihan yang tersedia terbatas.

   Apakah strategi penjadwalan pelatihan yang paling tepat diterapkan oleh koordinator?

   A. Mengirimkan seluruh bidan mengikuti pelatihan pada waktu yang sama agar kompetensi cepat merata
   B. Melakukan analisis kebutuhan, menentukan materi prioritas, menjadwalkan peserta secara bergantian, dan memadukan pembelajaran daring dengan simulasi
   C. Memprioritaskan bidan senior karena memiliki tanggung jawab terbesar dalam pelayanan
   D. Memberikan bahan bacaan kepada seluruh bidan tanpa membuat jadwal dan evaluasi khusus
   E. Menunda seluruh pelatihan sampai jumlah tenaga bidan di ruang bersalin bertambah

3. Sebanyak 12 bidan puskesmas telah mengikuti pelatihan daring mengenai penatalaksanaan persalinan sungsang. Hasil post-test menunjukkan seluruh peserta memperoleh nilai lebih dari 85. Namun, ketika dilakukan latihan informal, beberapa bidan belum mampu menyusun urutan tindakan secara benar, tidak melakukan pemantauan DJJ secara konsisten, dan belum mampu memberikan penjelasan yang jelas kepada ibu. Kepala puskesmas ingin mengetahui apakah peserta benar-benar mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi klinis yang disimulasikan.

   Apakah metode evaluasi yang paling tepat digunakan?

   A. Mengulang post-test dengan pertanyaan yang lebih sulit
   B. Menilai jumlah kehadiran peserta selama pelatihan daring
   C. Melaksanakan OSCE menggunakan skenario, pasien simulasi, dan daftar tilik terstandar
   D. Menyebarkan kuesioner kepuasan peserta terhadap narasumber pelatihan
   E. Meminta peserta menulis ringkasan materi penatalaksanaan persalinan sungsang

4. Pada sif malam di ruang bersalin, seorang bidan junior hampir memberikan oksitosin dengan dosis yang tidak sesuai karena salah membaca instruksi. Kesalahan tersebut diketahui oleh bidan lain sebelum obat diberikan sehingga tidak menimbulkan cedera pada pasien. Bidan senior kemudian meminta bidan junior menghapus catatan kejadian tersebut agar nilai mutu ruangan tidak menurun. Bidan junior merasa takut melaporkan kejadian karena khawatir dipermalukan dan mendapat hukuman.

Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan oleh koordinator ruang bersalin?

A. Memastikan kejadian didokumentasikan dan dilaporkan, melakukan pembahasan secara rahasia, serta menyusun perbaikan sistem dan pembinaan yang adil
B. Membiarkan kejadian tidak dilaporkan karena obat belum diberikan kepada pasien
C. Mengumumkan kesalahan bidan junior dalam rapat agar menjadi pelajaran bagi seluruh tenaga
D. Memindahkan bidan junior ke unit lain tanpa melakukan analisis terhadap penyebab kejadian
E. Menunggu sampai terjadi cedera pasien sebelum melakukan evaluasi terhadap prosedur pemberian obat

5. Hasil audit triwulan di sebuah puskesmas menunjukkan beberapa permasalahan. Bidan baru belum memahami pembagian kewenangan dan sering melakukan tindakan berdasarkan kebiasaan bidan senior. Pelatihan kegawatdaruratan dilakukan tidak terjadwal sehingga beberapa sif kekurangan tenaga. Selain itu, proses serah terima pasien sering tidak lengkap dan staf cenderung saling menyalahkan ketika terjadi kesalahan. Kepala puskesmas ingin melakukan perbaikan menyeluruh terhadap manajemen SDM kebidanan.

   Apakah program perbaikan yang paling tepat diterapkan?

   A. Menambah jumlah bidan tanpa mengevaluasi kompetensi, kewenangan, dan budaya kerja
   B. Mengadakan satu kali seminar motivasi dan menyerahkan perubahan kepada masing-masing bidan

C. Memberikan hukuman kepada staf yang melakukan kesalahan agar kedisiplinan meningkat
D. Memperbarui SPO tanpa memberikan sosialisasi, pelatihan, supervisi, dan evaluasi penerapan
E. Memetakan kompetensi, memperjelas kewenangan dan SPO, menjadwalkan pelatihan bergilir, memperkuat supervisi, serta membangun komunikasi professional

Kunci Jawaban

1. D
2. B
3. C
4. A
5. E

Pembahasan

1. Jawaban: **D.** Melakukan stabilisasi awal, menjelaskan kondisi kepada keluarga, menghubungi rumah sakit, dan segera menyiapkan rujukan.
   Kata kunci: presentasi bokong, kala I fase aktif, fasilitas terbatas, keselamatan pasien, kewenangan bidan, rujukan.
   Ibu mengalami persalinan kala I fase aktif dengan presentasi bokong. Walaupun kondisi ibu dan janin masih stabil, persalinan sungsang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan persalinan dengan presentasi kepala, antara lain prolaps tali pusat, terjepitnya kepala terakhir, trauma lahir, dan asfiksia. Puskesmas tidak memiliki dokter jaga dan hanya mempunyai fasilitas dasar, sedangkan persalinan belum memasuki kondisi sangat lanjut atau kelahiran belum segera terjadi. Oleh karena itu, rujukan terencana setelah stabilisasi merupakan

keputusan yang paling mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.

Bidan perlu memantau tanda vital ibu, DJJ, frekuensi dan durasi kontraksi, pembukaan serviks, serta tanda-tanda persalinan yang berkembang cepat. Bidan juga harus menjelaskan alasan rujukan kepada ibu dan keluarga, memperoleh persetujuan, menghubungi rumah sakit tujuan, menyiapkan transportasi, dokumen, alat dan obat yang diperlukan, serta memastikan ibu didampingi tenaga kesehatan selama perjalanan. Apabila persalinan berkembang sangat cepat dan kelahiran menjadi tidak dapat ditunda, bidan harus memberikan pertolongan kegawatdaruratan sesuai kompetensi dan SPO sambil tetap mengupayakan bantuan rujukan.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. A: Menunggu sampai pembukaan lengkap dapat mempersempit waktu yang tersedia untuk melakukan rujukan.
b. B: Amniotomi dapat meningkatkan risiko prolaps tali pusat pada presentasi bokong dan tidak boleh dilakukan hanya untuk mempercepat persalinan.
c. C: Riwayat pernah melahirkan tidak menghilangkan risiko persalinan sungsang maupun keterbatasan fasilitas.
d. E: Mengubah presentasi janin secara manual pada persalinan aktif bukan tindakan rutin yang dapat dilakukan tanpa kompetensi, fasilitas, dan indikasi yang jelas.

2. Jawaban: **B**. Melakukan analisis kebutuhan, menentukan materi prioritas, menjadwalkan peserta secara bergantian, dan memadukan pembelajaran daring dengan simulasi.

Kata kunci: *Training Need Analysis*, rotasi pelatihan, *blended learning*, kesinambungan pelayanan, evaluasi kompetensi.

Pelatihan harus didasarkan pada masalah nyata yang ditemukan dalam pelayanan. Data menunjukkan bahwa kebutuhan utama adalah peningkatan kemampuan mengenali kegawatdaruratan maternal dan memperbaiki dokumentasi rujukan. Karena itu, koordinator perlu melakukan *Training Need Analysis* untuk menentukan kesenjangan kompetensi, materi prioritas, peserta, metode, serta waktu pelatihan. Pelatihan tidak seharusnya dilaksanakan hanya berdasarkan keinginan peserta atau ketersediaan penyelenggara.

Model rotasi memungkinkan bidan mengikuti pelatihan secara bergantian tanpa menghentikan pelayanan. Materi teori dapat diberikan secara daring, sedangkan keterampilan klinis dilatih melalui simulasi, workshop, atau *on-the-job training*. Setelah pelatihan, evaluasi perlu dilakukan melalui pre-test dan post-test, observasi praktik, audit dokumentasi, serta penilaian kinerja. Dengan demikian, pelatihan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menghasilkan perubahan perilaku dan mutu pelayanan.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. A: Mengirim seluruh bidan pada waktu yang sama dapat menyebabkan kekurangan tenaga dan mengganggu pelayanan.
b. C: Pelatihan harus diberikan berdasarkan kesenjangan kompetensi, bukan hanya senioritas.
c. D: Bahan bacaan tanpa jadwal, praktik, dan evaluasi tidak cukup untuk memastikan peningkatan keterampilan.

d. E: Menunda pelatihan mempertahankan risiko kesalahan dan tidak menyelesaikan kesenjangan kompetensi yang sudah ditemukan.

3. Jawaban: C. Melaksanakan OSCE menggunakan skenario, pasien simulasi, dan daftar tilik terstandar.

   Kata kunci: Piramida Miller, *Shows How*, OSCE, simulasi klinis, daftar tilik.

   Nilai post-test yang tinggi menunjukkan bahwa peserta telah mencapai kemampuan pada tingkat "mengetahui" atau "mengetahui bagaimana" menurut Piramida Miller. Namun, hasil tersebut belum membuktikan bahwa peserta mampu menerapkan pengetahuan dalam tindakan klinis. Ketika ditemukan kesalahan urutan tindakan, kurangnya pemantauan DJJ, dan komunikasi yang belum efektif, evaluasi harus diarahkan pada kemampuan mendemonstrasikan tindakan atau tingkat *Shows How*.

   OSCE merupakan metode yang tepat karena peserta harus menghadapi skenario klinis terstandar, melakukan tindakan sesuai urutan, berkomunikasi dengan pasien simulasi, mengantisipasi kegawatdaruratan, dan menerapkan prinsip keselamatan pasien. Penilaian menggunakan daftar tilik memungkinkan aspek teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan dinilai secara objektif. Hasil OSCE juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pelatihan ulang atau supervisi klinis.

   Alasan opsi lain tidak tepat:

   a. A: Post-test hanya menilai pengetahuan dan penalaran, bukan kemampuan mendemonstrasikan tindakan.
   b. B: Kehadiran tidak menunjukkan bahwa peserta telah menguasai kompetensi.

c. D: Kepuasan peserta menilai penyelenggaraan pelatihan, bukan kemampuan klinis.
d. E: Ringkasan materi hanya menunjukkan kemampuan memahami dan menuliskan kembali pengetahuan.

4. Jawaban: A. Memastikan kejadian didokumentasikan dan dilaporkan, melakukan pembahasan secara rahasia, serta menyusun perbaikan sistem dan pembinaan yang adil.
Kata kunci: budaya keselamatan, *near miss*, integritas, akuntabilitas, pembelajaran organisasi.
Kejadian tersebut merupakan *near miss* atau kejadian hampir cedera karena kesalahan ditemukan sebelum obat diberikan kepada pasien. Walaupun tidak menimbulkan kerugian langsung, kejadian tetap perlu dilaporkan karena dapat menunjukkan kelemahan dalam sistem, seperti instruksi yang tidak jelas, penyimpanan obat yang membingungkan, kurangnya verifikasi dosis, kelelahan tenaga, atau supervisi yang tidak memadai. Menghapus catatan bertentangan dengan integritas, tanggung jawab, dan budaya profesional.
Koordinator harus menciptakan lingkungan yang mendorong staf melaporkan kesalahan tanpa rasa takut, tetapi tetap mempertahankan akuntabilitas. Pembahasan dilakukan secara rahasia dan berfokus pada penyebab kejadian, bukan mempermalukan individu. Tindak lanjut dapat berupa perbaikan prosedur pemberian obat, penerapan pemeriksaan ulang, pembinaan staf, supervisi, dan pelatihan keselamatan pasien. Apabila ditemukan pelanggaran yang disengaja, tindakan disiplin tetap dapat diberikan secara proporsional dan adil.
Alasan opsi lain tidak tepat:

a. B: Tidak melaporkan *near miss* menyebabkan organisasi kehilangan kesempatan untuk mencegah kejadian serupa.
b. C: Mempermalukan staf dapat menimbulkan budaya takut dan membuat tenaga enggan melaporkan kesalahan.
c. D: Memindahkan staf tanpa analisis tidak menyelesaikan penyebab dasar dalam sistem pelayanan.
d. E: Evaluasi harus dilakukan sebelum terjadi cedera, bukan setelah pasien mengalami kerugian.

5. Jawaban: E. Memetakan kompetensi, memperjelas kewenangan dan SPO, menjadwalkan pelatihan bergilir, memperkuat supervisi, serta membangun komunikasi profesional.

   Kata kunci: manajemen SDM berbasis kompetensi, kewenangan, pelatihan, supervisi, budaya profesional.

   Masalah dalam kasus tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga, tetapi meliputi ketidakjelasan kewenangan, kesenjangan kompetensi, penjadwalan pelatihan yang tidak efektif, lemahnya serah terima, dan budaya saling menyalahkan. Oleh karena itu, perbaikan tidak dapat dilakukan melalui satu intervensi terpisah. Kepala puskesmas perlu menerapkan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dengan memetakan kemampuan setiap bidan, menempatkan tenaga sesuai kompetensi, memperjelas batas kewenangan, serta menyosialisasikan SPO.

   Pelatihan harus disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan dilaksanakan secara bergilir agar tidak mengganggu pelayanan. Supervisi klinis, audit praktik, penilaian kinerja, dan umpan balik diperlukan untuk memastikan

kompetensi diterapkan dalam pelayanan. Pada saat yang sama, pimpinan harus menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang terbuka, serah terima terstandar, kerja sama tim, integritas, dan budaya keselamatan. Integrasi tersebut akan meningkatkan mutu pelayanan, kepercayaan pasien, serta keselamatan ibu dan bayi.

Alasan opsi lain tidak tepat:

a. A: Penambahan jumlah tenaga tidak otomatis menyelesaikan masalah kompetensi, kewenangan, dan budaya kerja.
b. B: Seminar motivasi satu kali tidak cukup untuk menghasilkan perubahan sistem dan perilaku yang berkelanjutan.
c. C: Hukuman tanpa analisis dapat memperkuat budaya saling menyalahkan dan menurunkan keterbukaan staf.
d. D: SPO yang tidak disosialisasikan, dilatih, dan diawasi cenderung tidak diterapkan secara konsisten.

## I. Referensi


Armstrong, M. (2022). *Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice*. London: Kogan Page.

Dessler, G. (2020). *Human Resource Management (16th ed.)*. Pearson.

Ikatan Bidan Indonesia. (2022). *Kode Etik Bidan Indonesia*. Jakarta: IBI.

International Confederation of Midwives. (2021). *Essential competencies for midwifery practice (Updated 2021)*. The Hague: ICM.

International Confederation of Midwives. (2021). *Global standards for midwifery education (Revised 2021)*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Standar Profesi Bidan Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kemenkes RI.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2021). *Leadership Roles and Management Functions in Nursing (10th ed.)*. Philadelphia: Wolters Kluwer.

Notoatmodjo, S. (2020). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.

World Health Organization. (2019). *WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2020). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors (2nd ed.)*. Geneva: WHO.

World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO.

# BAB 3

# MUTU PELAYANAN KEBIDANAN: STANDAR MUTU, INDIKATOR, DAN PENGUKURAN KINERJA

**Tabel CPL**

| Kode CPL | Rumusan CPL | CPMK yang berkontribusi |
|---|---|---|
| CPL-1 | Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan pelayanan kebidanan. | CPMK-1; CPMK-2; CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-2 | Menerapkan komunikasi efektif dan kolaborasi lintas profesi/jejaring dalam tata kelola layanan kebidanan berpusat pada klien. | CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-7 |
| CPL-3 | Menerapkan prinsip keselamatan pasien, PPI, dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan layanan. | CPMK-5; CPMK-6; CPMK-2 |
| CPL-4 | Mengelola mutu layanan melalui standar, indikator, audit, dan perbaikan berkelanjutan berbasis data. | CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7 |
| CPL-5 | Mengelola sumber daya (SDM, sarpras, alat, obat/BHP, dan keuangan) secara efisien dan akuntabel. | CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7; CPMK-2 |
| CPL-6 | Mengelola dokumentasi, informasi, dan kerahasiaan data serta evaluasi pengalaman klien (kepuasan/keluhan). | CPMK-6; CPMK-7; CPMK-4 |

**Tabel CPMK**

| Kode CPMK | Rumusan CPMK |
|---|---|
| CPMK-1 | Menganalisis regulasi, kewenangan, dan prinsip tata kelola TPMB untuk memastikan kepatuhan, etika, dan akuntabilitas. |
| CPMK-2 | Merancang perencanaan layanan TPMB (visi–misi, paket layanan, alur pelayanan, dan SOP inti) berbasis kebutuhan klien dan risiko. |
| CPMK-3 | Menyusun sistem manajemen SDM dan pengembangan kompetensi (kewenangan, penjadwalan, pelatihan, budaya profesional) untuk mendukung kinerja tim. |
| CPMK-4 | Mengembangkan dan mengevaluasi sistem manajemen mutu (standar, indikator, pengukuran kinerja, audit, dan rencana peningkatan mutu) berbasis data. |
| CPMK-5 | Merancang dan menerapkan program keselamatan pasien dan manajemen risiko termasuk PPI, pelaporan insiden, RCA, dan CAPA. |
| CPMK-6 | Mengelola sarana-prasarana, alat, obat, BHP, rekam medis, serta keamanan informasi untuk menjamin ketersediaan, keselamatan, dan kepatuhan. |
| CPMK-7 | Mengelola jejaring rujukan, komunikasi layanan, kepuasan/keluhan klien, dan aspek keuangan dasar untuk keberlanjutan layanan. |

**Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK**

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 1. Konsep Dasar Manajemen Pelayanan Kebidanan dan Tata Kelola TPMB | 1.1 Menguraikan kerangka regulasi, kewenangan praktik, dan prinsip tata kelola TPMB. | 1.2 Menilai kesiapan tata kelola (struktur, kebijakan, dokumentasi, peran) untuk akuntabilitas dan mutu dasar. | CPMK-1 | CPMK-4; CPMK-5 |
| Bab 2. Perencanaan Layanan TPMB: Visi–Misi, Paket Layanan, Alur Pelayanan, dan Standar Operasional | 2.1 Merumuskan visi–misi, sasaran layanan, dan paket layanan berbasis kebutuhan klien dan risiko. | 2.2 Menyusun alur pelayanan dan SOP inti yang memuat titik kontrol keselamatan. | CPMK-2 | CPMK-1; CPMK-6 |
| Bab 3. Manajemen SDM dan Kompetensi: Kewenangan, Penjadwalan, Pelatihan, dan Budaya Profesional | 3.1 Menetapkan kewenangan/uraian tugas dan penjadwalan berbasis beban kerja dan keselamatan. | 3.2 Merancang pelatihan, supervisi, dan strategi budaya profesional (etik, teamwork, disiplin mutu). | CPMK-3 | CPMK-1; CPMK-4 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 4. Mutu Pelayanan Kebidanan: Standar Mutu, Indikator, dan Pengukuran Kinerja | 4.1 Menetapkan standar mutu dan indikator prioritas beserta definisi operasionalnya. | 4.2 Melakukan pengukuran kinerja dan analisis hasil untuk rekomendasi perbaikan. | CPMK-4 | CPMK-2; CPMK-3 |
| Bab 5. Keselamatan Pasien di TPMB: Identifikasi Risiko, Pencegahan Insiden, dan Keselamatan Klinis | 5.1 Mengidentifikasi bahaya dan risiko keselamatan pasien pada alur layanan. | 5.2 Menyusun strategi pencegahan insiden dan rencana respons kejadian. | CPMK-5 | CPMK-2; CPMK-4 |
| Bab 6. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI): APD, Sterilisasi, Limbah Medis, dan Sanitasi | 6.1 Memilih tindakan PPI (APD, kebersihan tangan, dekontaminasi/sterilisasi) sesuai tingkat risiko. | 6.2 Menyusun sistem pengelolaan limbah medis dan sanitasi lingkungan sesuai standar. | CPMK-5 | CPMK-6; CPMK-4 |
| Bab 7. Manajemen Sarana, Prasarana, | 7.1 Menilai kesiapan ruang (layout, zonasi, alur bersih–kotor) untuk | 7.2 Menyusun rencana kalibrasi, | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-2 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| dan Alat: Kesiapan Ruang, Kalibrasi, dan Pemeliharaan | keselamatan dan efisiensi. | pemeliharaan, dan pencatatan alat. | | |
| Bab 8. Manajemen Obat dan Bahan Habis Pakai: Perencanaan, Penyimpanan, Logistik, dan Kedaluwarsa | 8.1 Menyusun perencanaan kebutuhan obat/BHP berbasis pola layanan, stok minimum, dan anggaran. | 8.2 Menerapkan sistem penyimpanan dan monitoring (FEFO/FIFO, kedaluwarsa, kartu stok). | CPMK-6 | CPMK-5; CPMK-7 |
| Bab 9. Manajemen Rekam Medis dan Kerahasiaan Data: Standar Pencatatan, Audit Trail, dan Keamanan Informasi | 9.1 Menerapkan standar pencatatan rekam medis dan audit trail (lengkap, tepat waktu, dapat telusur). | 9.2 Merancang kontrol kerahasiaan dan keamanan informasi (akses, backup, respons insiden). | CPMK-6 | CPMK-1; CPMK-4 |
| Bab 10. Manajemen Rujukan dan Jejaring Pelayanan: Kolaborasi, Komunikasi, | 10.1 Menyusun prosedur rujukan aman (kriteria, stabilisasi awal, komunikasi, dokumentasi). | 10.2 Membangun jejaring kolaborasi dan mekanisme | CPMK-7 | CPMK-2; CPMK-5 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| dan Transport Aman | | umpan balik rujukan. | | |
| Bab 11. Manajemen Keuangan TPMB: Tarif, Pembukuan, Pengendalian Biaya, dan Pelaporan | 11.1 Menyusun struktur tarif dan paket pembayaran yang transparan dan konsisten. | 11.2 Menerapkan pembukuan, pengendalian biaya, dan pelaporan untuk keputusan manajerial. | CPMK-7 | CPMK-6; CPMK-1 |
| Bab 12. Manajemen Risiko dan Pelaporan Insiden: RCA, CAPA, dan Perbaikan Berkelanjutan | 12.1 Mengoperasionalkan pelaporan insiden secara non-punitif, tepat waktu, dan dapat ditindaklanjuti. | 12.2 Melakukan RCA dan menetapkan CAPA serta monitoring efektivitas. | CPMK-5 | CPMK-4; CPMK-1 |
| Bab 13. Kepuasan Klien dan Pengelolaan Keluhan: Survei, Umpan Balik, dan Service Recovery | 13.1 Merancang survei kepuasan dan kanal umpan balik dengan indikator layanan yang relevan. | 13.2 Menyusun mekanisme penanganan keluhan dan service recovery berbasis SLA dan dokumentasi. | CPMK-7 | CPMK-4; CPMK-2 |

| Bab & Judul Bab | Sub-CPMK 1 | Sub-CPMK 2 | CPMK Utama | CPMK Penguat |
|---|---|---|---|---|
| Bab 14. Audit Mutu dan Akreditasi: Persiapan Dokumen, Simulasi Penilaian, dan Rencana Peningkatan Mutu | 14.1 Menyusun rencana audit mutu internal dan kesiapan dokumen akreditasi. | 14.2 Melaksanakan simulasi penilaian, analisis gap, dan rencana peningkatan mutu. | CPMK-4 | CPMK-1; CPMK-7 |

**Tabel Asesmen (berbasis CPMK)**

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| CPMK-1 | Tes tertulis berbasis kasus; analisis dokumen | Ketepatan identifikasi regulasi/kewenangan; rekomendasi kontrol kepatuhan dan akuntabilitas yang operasional | 10 | Lembar jawaban studi kasus; ringkasan analisis kepatuhan |
| CPMK-2 | Proyek perencanaan layanan; penilaian dokumen SOP | Visi–misi dan sasaran terukur; alur layanan lengkap; SOP memuat langkah, penanggung jawab, dan titik kontrol keselamatan | 15 | Dokumen rencana layanan; flowchart alur; SOP inti |
| CPMK-3 | Proyek manajemen SDM; studi | Pemetaan kewenangan/uraian tugas jelas; jadwal memenuhi | 10 | Dokumen SDM (credentialing, jadwal); |

| Kode CPMK | Teknik/Instrumen | Indikator Penilaian (inti, terukur) | Bobot (%) | Bukti/Produk |
|---|---|---|---|---|
| | kasus penjadwalan | kebutuhan layanan; rencana pelatihan berbasis gap; strategi budaya profesional terukur | | rencana pelatihan/supervisi |
| CPMK-4 | Tugas dashboard indikator; audit mini; presentasi | Definisi operasional indikator jelas; perhitungan indikator akurat; analisis temuan berbasis data; rencana perbaikan dengan target, PIC, dan waktu | 20 | Dashboard indikator; laporan audit; rencana PDSA/RPM |
| CPMK-5 | Simulasi tabletop keselamatan; workshop RCA/CAPA | Identifikasi risiko pada skenario; rancangan mitigasi sesuai prioritas; pelaporan insiden lengkap; RCA logis; CAPA SMART dan ada monitoring | 20 | Checklist risiko; formulir insiden; laporan RCA & CAPA |
| CPMK-6 | Praktik penyusunan logbook; audit kepatuhan dokumentasi | Inventaris/kalibrasi/pemeliharaan lengkap; logistik obat/BHP menerapkan FEFO dan stok minimum; kelengkapan pencatatan; kontrol akses/backup terdokumentasi | 15 | Logbook alat; kartu stok; contoh rekam medis; SOP keamanan informasi |
| CPMK-7 | Studi kasus rujukan & komunikasi; tugas keuangan; survei layanan | Kriteria & alur rujukan aman; komunikasi terstruktur (mis. SBAR) dan dokumentasi rujukan; tarif/pembukuan konsisten; instrumen kepuasan & alur keluhan dengan SLA | 10 | SOP rujukan + contoh komunikasi; template pembukuan; instrumen survei & alur keluhan |

**Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)**

Rubrik CPMK-1

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Ketepatan identifikasi regulasi/kewenangan dan risiko kepatuhan | Banyak tidak tepat/tidak relevan; risiko kepatuhan tidak teridentifikasi | Sebagian tepat; masih ada kekeliruan/kelalaian penting | Hampir seluruhnya tepat; hanya kekurangan minor | Lengkap dan akurat; risiko kepatuhan terpetakan jelas dan relevan |
| 1.2 Kualitas rekomendasi tata kelola (kebijakan, peran, dokumentasi, kontrol) | Rekomendasi umum/tidak operasional; tanpa kontrol | Ada rekomendasi, tetapi belum prioritatif/kurang operasional | Rekomendasi operasional, prioritas cukup jelas, kontrol memadai | Rekomendasi sangat operasional, prioritas berbasis risiko, kontrol dan monitoring jelas |

**Rubrik CPMK-2**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 Kejelasan visi–misi, sasaran, dan paket layanan | Tidak konsisten; sasaran tidak terukur; paket layanan tidak sesuai kebutuhan | Cukup konsisten; sasaran sebagian terukur; paket layanan masih kurang lengkap | Konsisten; sasaran terukur; paket layanan sesuai kebutuhan utama | Sangat konsisten; sasaran SMART; paket layanan komprehensif dan berbasis kebutuhan/risiko |
| 2.2 Kelengkapan alur layanan dan SOP inti dengan kontrol keselamatan | Alur tidak lengkap; SOP tidak jelas; kontrol keselamatan tidak ada | Alur cukup; SOP ada namun langkah/PIC kurang jelas; kontrol terbatas | Alur lengkap; SOP jelas (langkah, PIC, dokumen); kontrol keselamatan memadai | Alur sangat rapi; SOP sangat operasional; kontrol keselamatan kritis terintegrasi dan mudah diaudit |

**Rubrik CPMK-3**

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 Ketepatan kewenangan/uraian tugas dan penjadwalan | Kewenangan tidak jelas; jadwal tidak realistis/abaikan keselamatan | Kewenangan cukup; jadwal berjalan tetapi belum berbasis | Kewenangan jelas; jadwal berbasis beban kerja dan kontinuitas layanan | Kewenangan sangat jelas (termasuk mekanisme delegasi); jadwal optimal |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| | | beban kerja | | dan mitigasi risiko kelelahan |
| 3.2 Desain pengembangan kompetensi dan budaya profesional | Tidak berbasis kebutuhan; tanpa mekanisme supervisi | Ada pelatihan, tetapi belum berbasis gap; budaya profesional belum terukur | Pelatihan berbasis gap; supervisi terencana; intervensi budaya profesional jelas | Pelatihan berjenjang; supervisi & evaluasi kuat; budaya profesional dibangun dengan indikator dan tindak lanjut |

Rubrik CPMK-4

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 Perumusan indikator mutu dan pengolahan data | Indikator tidak jelas; definisi operasional tidak ada; data tidak valid | Indikator ada namun definisi operasional kurang; pengolahan data terbatas | Indikator prioritas jelas; definisi operasional lengkap; perhitungan akurat | Indikator sangat tepat; data tervalidasi; analitik (tren/segmentasi) memperkuat keputusan |
| 4.2 Analisis temuan dan rencana | Tidak ada analisis; rencana | Analisis dasar; rencana | Analisis berbasis data; | Analisis mendalam (akar masalah); rencana |

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| peningkatan mutu | perbaikan tidak spesifik | perbaikan belum SMART | rencana perbaikan SMART dengan PIC & waktu | perbaikan terukur, berprioritas, serta rencana evaluasi efektivitas jelas |

Rubrik CPMK-5

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 Identifikasi risiko dan desain mitigasi keselamatan/PPI | Risiko tidak terpetakan; mitigasi tidak sesuai/umum | Risiko teridentifikasi sebagian; mitigasi ada tetapi tidak prioritatif | Risiko terpetakan; mitigasi sesuai prioritas dan alur kerja | Risiko terpetakan komprehensif; mitigasi kuat (hierarki kontrol) dan ada indikator pemantauan |
| 5.2 Kualitas pelaporan insiden serta RCA dan CAPA | Laporan tidak lengkap; RCA/CAPA tidak logis | Laporan cukup; RCA masih dangkal; CAPA belum SMART | Laporan lengkap; RCA logis; CAPA SMART dengan monitoring | Laporan sangat lengkap dan tepat waktu; RCA tajam; CAPA terukur, feasible, dan mekanisme evaluasi efektivitas jelas |

Rubrik CPMK-6

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 Manajemen sarpras/alat/obat-BHP (ketersediaan, pemeliharaan, logistik) | Inventaris/logistik tidak rapi; tidak ada jadwal pemeliharaan; stok sering tidak terkendali | Ada inventaris dan logistik, namun belum konsisten; pemeliharaan belum terjadwal baik | Inventaris lengkap; pemeliharaan/kalibrasi terjadwal; FEFO/FIFO dan stok minimum berjalan | Sistem sangat tertata; pemeliharaan proaktif; kontrol stok kuat (early warning) dan terdokumentasi |
| 6.2 Dokumentasi rekam medis dan keamanan informasi | Pencatatan tidak lengkap; akses data tidak terkontrol; tidak ada backup | Pencatatan cukup; kontrol akses dasar; backup belum rutin | Pencatatan lengkap dan dapat telusur; kontrol akses jelas; backup rutin | Pencatatan sangat konsisten; audit trail kuat; keamanan informasi komprehensif termasuk respons insiden |

Rubrik CPMK-7

| Indikator | Skor 1 (Kurang) | Skor 2 (Cukup) | Skor 3 (Baik) | Skor 4 (Sangat Baik) |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 Manajemen rujukan & jejaring (komunikasi, transport aman, umpan balik) | Kriteria/alur rujukan tidak jelas; komunikasi tidak terstruktur; umpan balik tidak ada | Alur rujukan ada; komunikasi cukup; umpan balik belum konsisten | Rujukan aman (kriteria, stabilisasi, dokumen); komunikasi terstruktur; umpan balik berjalan | Rujukan sangat siap dan teruji; komunikasi sangat efektif; jejaring aktif dengan mekanisme evaluasi jejaring |
| 7.2 Keuangan dasar & pengalaman klien (kepuasan/keluhan/ service recovery) | Tarif/pembukuan tidak konsisten; survei/keluhan tidak dikelola | Tarif/pembukuan dasar ada; survei/keluhan ada tetapi tanpa SLA jelas | Tarif transparan; pembukuan rapi; survei dan keluhan dikelola dengan SLA & dokumentasi | Keuangan informatif untuk keputusan; survei bermakna; service recovery efektif dan menjadi input perbaikan mutu berkelanjutan |

**Uraian Materi**

Mutu pelayanan kebidanan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Pelayanan yang bermutu tidak hanya berfokus pada hasil klinis, tetapi juga pada proses pelayanan, keselamatan pasien, serta kepuasan pengguna layanan.

Dalam Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB), penerapan manajemen mutu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi, berbasis bukti ilmiah, serta berorientasi pada keselamatan pasien (patient safety).

## A. Konsep Mutu Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Mutu Pelayanan

   Mutu pelayanan adalah tingkat kesempurnaan pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan mampu memenuhi kebutuhan serta harapan pasien.

2. Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan

   Mutu pelayanan kebidanan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu:

   a. Keamanan (safety): Pelayanan bebas dari risiko cedera
   b. Efektivitas: Berdasarkan evidence-based practice
   c. Efisiensi: Optimal dalam penggunaan sumber daya
   d. Keadilan (equity): Pelayanan tanpa diskriminasi
   e. Berorientasi pasien (patient-centered care)
   f. Ketepatan waktu (timeliness)

3. Prinsip Mutu Pelayanan Kebidanan

a. Berbasis standar profesi
b. Mengutamakan keselamatan pasien
c. Berkelanjutan (continuous quality improvement)
d. Berorientasi pada kepuasan pasien
e. Berbasis data dan evaluasi

## B. Standar Mutu Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Standar Mutu

   Standar mutu adalah kriteria atau ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan kebidanan.

2. Jenis Standar Mutu
   a. Standar Struktur
      Meliputi:
      1) Ketersediaan SDM kompeten
      2) Sarana dan prasarana
      3) Peralatan medis
   b. Standar Proses
      Meliputi:
      1) Pelaksanaan pelayanan sesuai SOP
      2) Komunikasi efektif
      3) Dokumentasi pelayanan
   c. Standar Hasil (Outcome)
      Meliputi:
      1) Keberhasilan pelayanan
      2) Penurunan komplikasi
      3) Kepuasan pasien

3. Standar Mutu dalam TPMB
    a. Pelayanan sesuai standar praktik bidan
    b. Penggunaan SOP dalam setiap tindakan
    c. Penerapan keselamatan pasien
    d. Dokumentasi rekam medis yang lengkap

## C. Indikator Mutu Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Indikator Mutu

    Indikator mutu adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pelayanan kesehatan.

2. Kriteria Indikator Mutu
    a. Valid
    b. Reliabel
    c. Sensitif terhadap perubahan
    d. Mudah diukur
    e. Relevan dengan pelayanan
3. Jenis Indikator Mutu
    a. Indikator Struktur
        1) Rasio tenaga bidan terhadap pasien
        2) Ketersediaan alat medis
    b. Indikator Proses
        1) Kepatuhan terhadap SOP
        2) Ketepatan identifikasi pasien
        3) Pelaksanaan komunikasi efektif
    c. Indikator Outcome
        1) Angka komplikasi persalinan
        2) Angka rujukan

3) Tingkat kepuasan pasien

4. Contoh Indikator Mutu TPMB

| Indikator | Definisi | Target |
|---|---|---|
| Kepatuhan SOP | Persentase tindakan sesuai SOP | ≥ 90% |
| Kepuasan pasien | Tingkat kepuasan layanan | ≥ 85% |
| Rujukan tepat waktu | Persentase rujukan sesuai indikasi | ≥ 95% |
| Dokumentasi lengkap | Rekam medis lengkap | ≥ 90% |

## D. Pengukuran Kinerja Pelayanan Kebidanan

1. Pengertian Pengukuran Kinerja

   Pengukuran kinerja adalah proses evaluasi terhadap hasil kerja pelayanan kebidanan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

2. Tujuan Pengukuran Kinerja
   a. Menilai kualitas pelayanan
   b. Mengidentifikasi masalah pelayanan
   c. Mendukung pengambilan keputusan
   d. Meningkatkan mutu secara berkelanjutan
3. Metode Pengukuran Kinerja
   a. Audit Klinis
      Evaluasi pelayanan berdasarkan standar klinis.
   b. Audit Rekam Medis
      Menilai kelengkapan dokumentasi pelayanan.
   c. Survei Kepuasan Pasien
      Mengukur persepsi pasien terhadap pelayanan.

d. Observasi Langsung
   Penilaian terhadap praktik pelayanan di lapangan.
e. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicators/KPI)
   Menggunakan indikator kuantitatif untuk evaluasi.

4. Siklus Peningkatan Mutu (PDCA Cycle)
   a. Plan: Merencanakan perbaikan
   b. Do: Melaksanakan rencana
   c. Check: Evaluasi hasil
   d. Act: Tindak lanjut perbaikan

   Siklus ini dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan mutu pelayanan.

## E. Implementasi Mutu Pelayanan di TPMB

1. Langkah-langkah Implementasi
   a. Menetapkan standar mutu
   b. Menentukan indikator
   c. Melakukan pengukuran kinerja
   d. Evaluasi hasil
   e. Melakukan perbaikan berkelanjutan
2. Tantangan dalam Penerapan Mutu
   a. Keterbatasan SDM
   b. Kurangnya pelatihan
   c. Minimnya sistem monitoring
   d. Resistensi terhadap perubahan

3. Strategi Peningkatan Mutu
    a. Pelatihan berkelanjutan
    b. Penguatan SOP
    c. Monitoring dan evaluasi rutin
    d. Peningkatan budaya keselamatan pasien

## F. Integrasi Mutu dengan Keselamatan Pasien

Mutu pelayanan kebidanan tidak dapat dipisahkan dari keselamatan pasien. Upaya integrasi meliputi:

1. Identifikasi pasien secara tepat
2. Komunikasi efektif
3. Pencegahan infeksi
4. Pelaporan insiden keselamatan pasien
5. Eva luasi berkelanjutan

## G. Rangkuman

Mutu pelayanan kebidanan merupakan ukuran penting dalam keberhasilan pelayanan di TPMB. Standar mutu terdiri dari struktur, proses, dan outcome. Indikator mutu digunakan untuk menilai kinerja pelayanan, sedangkan pengukuran kinerja dilakukan melalui berbagai metode seperti audit dan survei. Peningkatan mutu dilakukan secara berkelanjutan melalui siklus PDCA dan terintegrasi dengan keselamatan pasien.

## H. Latihan Soal

1. Di TPMB Sehat Ibu terdapat dua bayi perempuan yang lahir pada hari yang sama. Kedua ibu bayi tersebut memiliki nama depan yang sama, yaitu Ny. Siti. Bayi pertama telah mendapatkan injeksi vitamin K1, sedangkan bayi kedua belum mendapatkannya. Pada saat pergantian sif, bidan jaga hampir memberikan injeksi vitamin K1 kembali kepada bayi pertama karena hanya menanyakan nama depan ibu. Kesalahan tersebut diketahui setelah bidan lain memeriksa rekam medis bayi.

   Tindakan perbaikan sistem yang paling tepat pada kasus tersebut adalah....

   A. Menempatkan kedua bayi pada ruang perawatan yang berbeda
   B. Mewajibkan penggunaan minimal dua identitas pasien sebelum setiap tindakan
   C. Meminta keluarga mengawasi seluruh tindakan yang dilakukan bidan
   D. Memberikan tanda khusus hanya pada bayi yang telah mendapatkan obat
   E. Menyerahkan seluruh pemberian obat kepada pemilik TPMB

2. Seorang bayi lahir di TPMB dengan kondisi tidak segera menangis, tonus otot lemah, dan napas tidak adekuat. Bidan segera memulai langkah awal resusitasi. Namun, saat akan melakukan ventilasi tekanan positif, ditemukan sungkup tidak sesuai ukuran dan balon resusitasi

mengalami kebocoran. Tabung oksigen cadangan juga dalam keadaan kosong. Kondisi tersebut menyebabkan tindakan resusitasi mengalami keterlambatan.

Indikator mutu yang paling tepat diprioritaskan untuk mencegah terulangnya kejadian tersebut adalah....

A. Persentase pasien yang merasa puas terhadap pelayanan persalinan
B. Persentase rekam medis persalinan yang terisi lengkap
C. Persentase rujukan kegawatdaruratan yang dilaksanakan tepat waktu
D. Persentase alat resusitasi neonatal yang tersedia, lengkap, dan berfungsi
E. Persentase kepatuhan bidan dalam melakukan komunikasi efektif

3. Pemilik TPMB melakukan evaluasi terhadap pelayanan rujukan selama tiga bulan terakhir. Berdasarkan data, terdapat 40 ibu dan bayi yang memenuhi indikasi rujukan. Dari jumlah tersebut, 37 pasien berhasil dirujuk sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam SOP, sedangkan tiga pasien mengalami keterlambatan karena koordinasi transportasi dan fasilitas rujukan. Target indikator rujukan tepat waktu di TPMB tersebut adalah minimal 95%.

   Kesimpulan dan tindak lanjut yang paling tepat adalah....

   A. Capaian sebesar 92,5%, belum memenuhi target, sehingga penyebab keterlambatan perlu diaudit dan diperbaiki

B. Capaian sebesar 95%, telah memenuhi target, sehingga prosedur rujukan dapat dipertahankan tanpa evaluasi
C. Capaian sebesar 97,5%, telah melampaui target, sehingga tidak diperlukan tindak lanjut
D. Capaian sebesar 90%, belum memenuhi target, tetapi evaluasi dapat dilakukan pada tahun berikutnya
E. Capaian sebesar 92,5%, telah memenuhi target karena nilainya sudah melebihi 90%

4. Hasil audit rekam medis di TPMB menunjukkan bahwa kelengkapan dokumentasi pelayanan kebidanan hanya mencapai 76%, sedangkan target yang ditetapkan adalah minimal 90%. Pemilik TPMB kemudian menyusun format checklist dokumentasi, memberikan pelatihan kepada seluruh bidan, dan menerapkan pemeriksaan rekam medis pada akhir setiap sif. Setelah dua bulan, audit ulang menunjukkan kelengkapan dokumentasi meningkat menjadi 92%.

   Tindakan yang paling tepat pada tahap **Act** dalam siklus PDCA adalah....

   A. Menghentikan penggunaan checklist karena target telah tercapai
   B. Mengulang tahap perencanaan tanpa menggunakan hasil audit ulang
   C. Menetapkan checklist sebagai prosedur baku dan melanjutkan monitoring secara berkala

D. Mengembalikan format dokumentasi lama agar pekerjaan bidan lebih cepat
E. Memberikan sanksi kepada seluruh bidan yang pernah mengisi rekam medis tidak lengkap

5. Seorang perempuan berusia 34 tahun, G3P2A0, usia kehamilan 36 minggu, datang ke TPMB dengan keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri ulu hati. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah 170/110 mmHg dan protein urine +3. Pada saat itu ruang tunggu dipenuhi pasien pemeriksaan kehamilan rutin. Karena TPMB belum memiliki sistem triase, pasien diminta menunggu berdasarkan urutan kedatangan dan baru diperiksa kembali 45 menit kemudian.
   Strategi peningkatan mutu yang paling tepat diterapkan adalah....
   A. Tetap menggunakan urutan kedatangan agar seluruh pasien memperoleh perlakuan yang sama
   B. Memberikan jalur prioritas kepada pasien yang membayar biaya pelayanan lebih tinggi
   C. Meminta pasien berisiko tinggi datang pada hari ketika jumlah pasien lebih sedikit
   D. Menambah survei kepuasan pasien tanpa mengubah alur penerimaan pasien
   E. Menerapkan triase klinis, jalur kegawatdaruratan, stabilisasi awal, dan rujukan segera

Kunci Jawaban

1. B
2. D
3. A
4. C
5. E

Pembahasan

1. Jawaban: **B.** Mewajibkan penggunaan minimal dua identitas pasien sebelum setiap tindakan

   Kasus tersebut merupakan kejadian nyaris cedera atau near miss karena kesalahan pemberian obat berhasil dicegah sebelum tindakan dilakukan. Akar masalahnya bukan sekadar kelalaian individu, tetapi lemahnya sistem identifikasi pasien. Penggunaan nama depan ibu sebagai satu-satunya identitas tidak memadai karena terdapat kemungkinan beberapa pasien memiliki nama yang sama. Perbaikan yang paling tepat adalah mewajibkan penggunaan minimal dua identitas, misalnya nama lengkap ibu, tanggal lahir ibu, nomor rekam medis, tanggal dan jam lahir bayi, atau identitas pada gelang bayi. Identitas harus dicocokkan dengan rekam medis dan instruksi tindakan sebelum obat atau pelayanan diberikan. Langkah ini merupakan bagian dari indikator proses dan integrasi mutu dengan keselamatan pasien.

   Pilihan A tidak menjamin ketepatan identifikasi karena kesalahan tetap dapat terjadi meskipun pasien ditempatkan di ruang berbeda. Pilihan C memindahkan tanggung jawab keselamatan kepada keluarga. Pilihan D

dapat menjadi langkah tambahan, tetapi tidak menggantikan prosedur dua identitas. Pilihan E tidak menyelesaikan kelemahan sistem dan tidak efisien untuk operasional TPMB.

2. Jawaban: **D**. Persentase alat resusitasi neonatal yang tersedia, lengkap, dan berfungsi

   Masalah utama dalam kasus tersebut adalah ketidaksiapan sarana dan peralatan kegawatdaruratan. Balon resusitasi yang bocor, sungkup yang tidak sesuai ukuran, dan tabung oksigen yang kosong menunjukkan kegagalan pada standar struktur. Standar struktur mencakup ketersediaan tenaga yang kompeten, sarana, prasarana, obat, serta peralatan medis yang lengkap dan berfungsi.

   Indikator yang perlu dipantau adalah persentase alat resusitasi neonatal yang tersedia, sesuai ukuran, dalam kondisi berfungsi, dan telah diperiksa sebelum pelayanan dimulai. TPMB dapat menggunakan checklist kesiapan alat pada setiap awal sif. Pemeriksaan rutin harus meliputi balon dan sungkup resusitasi, alat pengisap lendir, sumber oksigen, penghangat bayi, obat kegawatdaruratan, dan alat pelindung diri.

   Kepuasan pasien pada pilihan A merupakan indikator outcome. Kelengkapan rekam medis pada pilihan B dan komunikasi efektif pada pilihan E merupakan indikator proses. Ketepatan rujukan pada pilihan C juga penting, tetapi tidak secara langsung mengatasi penyebab

keterlambatan resusitasi, yaitu ketidaktersediaan dan ketidakberfungsian peralatan.

3. Jawaban: **A**. Capaian sebesar 92,5%, belum memenuhi target, sehingga penyebab keterlambatan perlu diaudit dan diperbaiki

   Capaian rujukan tepat waktu dihitung dengan rumus:

   Capaian=Jumlah rujukan tepat waktuJumlah seluruh pasien dengan indikasi rujukan×100%\text{Capaian}=\frac{\text{Jumlah rujukan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh pasien dengan indikasi rujukan}}\times 100\%Capaian=Jumlah seluruh pasien dengan indikasi rujukanJumlah rujukan tepat waktu×100%

   Capaian=3740×100%=92,5%\text{Capaian}=\frac{37}{40}\times 100\%=92,5\%Capaian=4037×100%=92,5%

   Hasil 92,5% masih berada di bawah target indikator rujukan tepat waktu, yaitu minimal 95%. Dengan demikian, indikator belum tercapai. TPMB harus melakukan audit terhadap tiga kasus yang terlambat untuk mengetahui faktor penyebab, seperti keterlambatan pengambilan keputusan, kesiapan transportasi, komunikasi dengan rumah sakit, penerimaan keluarga, atau tidak tersedianya daftar fasilitas rujukan.

   Perbaikan dapat dilakukan dengan membuat jejaring fasilitas rujukan, memperbarui nomor kontak rumah sakit dan ambulans, menyiapkan format komunikasi rujukan, memberikan edukasi rencana rujukan sejak pemeriksaan kehamilan, dan melakukan simulasi kegawatdaruratan. Pilihan E salah karena target untuk indikator rujukan

adalah 95%, bukan 90%. Pilihan B, C, dan D menggunakan perhitungan atau tindak lanjut yang tidak tepat.

4. Jawaban: C. Menetapkan checklist sebagai prosedur baku dan melanjutkan monitoring secara berkala

   Pada tahap Plan, TPMB mengidentifikasi rendahnya kelengkapan rekam medis dan merencanakan penggunaan checklist serta pelatihan. Tahap Do dilakukan dengan menerapkan checklist dan pemeriksaan dokumentasi pada akhir sif. Tahap Check dilakukan melalui audit ulang yang menunjukkan peningkatan dari 76% menjadi 92%.

   Karena hasil perbaikan telah memenuhi target minimal 90%, tahap selanjutnya adalah Act, yaitu menstandarkan perubahan yang terbukti efektif. Checklist perlu ditetapkan sebagai bagian dari SOP, disosialisasikan kepada tenaga baru, dan digunakan secara konsisten. Monitoring tetap harus dilakukan agar capaian tidak kembali menurun. Siklus PDCA dapat diulang apabila ditemukan masalah baru atau penurunan kinerja.

   Pilihan A dan D berisiko menyebabkan penurunan kembali kelengkapan dokumentasi. Pilihan B mengabaikan hasil evaluasi yang telah diperoleh. Pilihan E tidak sesuai dengan prinsip peningkatan mutu karena pendekatan utama seharusnya memperbaiki sistem, memberikan umpan balik, dan meningkatkan kompetensi, bukan langsung memberikan sanksi kepada seluruh tenaga.

5. Jawaban: **E.** Menerapkan triase klinis, jalur kegawatdaruratan, stabilisasi awal, dan rujukan segera
   Keluhan sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, tekanan darah 170/110 mmHg, dan protein urine +3 menunjukkan tanda kegawatdaruratan hipertensi dalam kehamilan. Pasien seperti ini tidak boleh menunggu berdasarkan urutan kedatangan karena keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko eklampsia, stroke, gangguan organ, solusio plasenta, hipoksia janin, dan kematian ibu atau bayi.
   TPMB perlu menerapkan triase klinis sejak pasien datang. Pasien dengan tanda kegawatdaruratan harus segera diprioritaskan, dilakukan penilaian cepat, stabilisasi awal sesuai kompetensi dan SOP, komunikasi efektif dengan fasilitas rujukan, serta rujukan tanpa penundaan. Strategi ini mencerminkan dimensi keamanan, efektivitas, ketepatan waktu, keadilan, dan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan pasien.
   Pilihan A keliru karena keadilan tidak selalu berarti melayani berdasarkan urutan kedatangan; pasien dengan kondisi lebih gawat harus memperoleh prioritas berdasarkan kebutuhan klinis. Pilihan B bersifat diskriminatif. Pilihan C memindahkan tanggung jawab kepada pasien. Pilihan D dapat memberikan informasi mengenai persepsi pasien, tetapi tidak mengatasi risiko keselamatan akibat tidak adanya sistem triase.

## I. Glosarium

TPMB: Tempat Praktik Mandiri Bidan

RCA: Root Cause Analysis

CAPA: Corrective and Preventive Action

PPI: Pencegahan dan Pengendalian Infeksi

SOP: Standar Operasional Prosedur

## J. Referensi


Donabedian, A. (1988). *The quality of care: How can it be assessed?* Journal of the American Medical Association.

Ikatan Bidan Indonesia (IBI). (2021). *Pedoman praktik mandiri bidan*.

Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Standar praktik bidan dan pelayanan kebidanan*.

Permenkes RI No. 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

Syafrudin, S., et al. (2021). *Manajemen mutu pelayanan kesehatan untuk bidan*. Trans Info Media.

WHO. (2022). *Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities*.

# PROFIL PENULIS



**Dr.Edi Murwani, A.Md.Keb., S.Pd., M.M.R.S., FISQua.,** Lahir di Malang, 21 Februari 1952. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 Sarjana (S1), Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Budi Utomo Malang. Pendidikan Bidan RS.Celaket Malang. Diploma Tiga Kebidanan, Poltekes Depkes RI Malang. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister (S2) Magister Manajemen, Minat Manajemen Rumah Sakit, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang. Lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan Program Doktor (S3) Ilmu Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga, Surabaya. Lulus th 2016. Mengikuti Program Fellowship International Society Quality of Healthcare (ISQua) mulai 2025 sd saat ini.

Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1974 di RSU Bojonegoro (sd. 1979) sebagai Kepala Ruangan Perinatologi, Pelaksana Kebidanan Kamar Bersalin dan Ruang Nifas, dan sebagai Tenaga Pengajar Sekolah Bidan Negeri Bojonegoro. Kemudian mulai tahun 1979 – 2008 di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang, sebagai Pelaksana Perawatan Paviliun, Pelaksana Kebidanan di Kamar Bersalin, Ruang 3 Obstetri dan Ruang 3 Gynaecology. Kemudian sebagai Kepala Ruangan di Ruang Paviliun C1 OBG, kemudian sebagai Kepala Ruangan di Paviliun Dahlia, Paviliun Lely, dan Paviliun Anggrek, kemudian sebagai Kepala Unit Pelaksana Perawatan Paviliun, kemudian sebagai Kepala Seksi Pendidikan dan Penelitian Tenaga Paramedis, kemudian sebagai Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sebagai Tim Akreditasi

Rumah Sakit, ISO 9001:2002, KARS, JCI, dan sebagai Tim Pembina Gugus Kendali Mutu Rumah Sakit.
Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes. Penulis sebagai Dosen Program Studi Kebidanan. Disamping itu sebagai Kepala Bidang Penjaminan Mutu, MR.ISO 9001: 2008, Tim Akreditasi Program Studi dan Tim Akreditasi Perguruan Tinggikemudian sebagai Wakil Ketua II, kemudian sebagai Wakil Ketua I, dan sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendedes (2011-2022). Saat ini sebagai Dosen Program Studi Kebidanan mengampu Mata Kuliah: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Etikolegal Pelayanan Kebidanan, Dokumentasi Kebidanan, Komunikasi Kebidanan, Manajemen Pelayanan Kebidanan, Psikologi Kehamilan, Persalinan dan Nifas. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis modul, publikasi, seminar, pengabdian pada masyarakat, orasi ilmiah, dan anggota organisasi profesi (Ikatan Bidan Indonesia), dan sebagai surveiyor Lembaga Akreditasi Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit (LAM-KPRS).Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: edimurwani@gmail.com
Motto: Pantang Menyerah

# PROFIL PENULIS



**Dr.Budi Astyandini,S.SiT.M.Kes.,** Dosen Program Studi Kebidanan Poltekkes Kemenkes Semarang. Riwayat Pendidikan: lulusan D1 PPB SPK Kariadi dan D3 Kebidanan Poltekes Semarang, D4 Pendidikan bidan pendidik Stikes Ngudiwaluyo Ungaran, S2 Kesehatan masyarakat Undip Semarang, S3 Manajemen Kependidikan UNNES.

Riwayat Pekerjaan: Pekerjaan utama menjadi dosen di Program studi Sarjana Kebidanan di Poltekkes Semarang, serta aktif di organisasi wanita diantaranya bidan sebagai sekretaris IBI Cabang Kendal, Perwari, GOW ,KPPI ,menjadi Fasilitator Nasional program ROOTS, Dosen Bimbel online,Dosen STT Hati Elok.

Aktifitas publikasi : Beberapa Buku di hasilkan berhubungan dengan profesionalisme bidan, Profesi bidan,Gender, remaja, Kehamilan, KB dan pembahasan soal UKOM kebidanan,kependidikan serta manajenemen kependidikan dalam bentuk artikel jurnal dan proceeding.

Penulis dapat dihubungi melalui email asty.budi@yahoo.com

## Sinopsis

Pengelolaan pelayanan kebidanan tidak hanya menuntut kecakapan klinis, tetapi juga kemampuan manajerial, kepemimpinan, pengendalian mutu, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat perlu dikelola secara profesional, aman, efektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada regulasi, standar profesi, etika, serta kebutuhan klien.

Buku ajar *Manajemen Pelayanan Kebidanan: Mutu, Keselamatan Pasien, dan Tata Kelola TPMB* menyajikan pembahasan sistematis mengenai pengelolaan pelayanan kebidanan, mulai dari konsep dasar manajemen, regulasi dan kewenangan praktik, prinsip tata kelola, perencanaan layanan, penyusunan alur pelayanan dan standar operasional prosedur, hingga pengelolaan sumber daya manusia serta pengembangan kompetensi dan budaya profesional.

Pembahasan selanjutnya mengarahkan pembaca pada penerapan standar mutu, penetapan indikator, pengukuran kinerja, keselamatan pasien, manajemen risiko, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Buku ini juga menguraikan pengelolaan sarana-prasarana dan alat, perencanaan obat serta bahan habis pakai, rekam medis dan kerahasiaan data, sistem rujukan dan jejaring pelayanan, manajemen keuangan TPMB, pelaporan insiden, analisis akar masalah melalui *Root Cause Analysis* (RCA), serta penyusunan *Corrective and Preventive Action* (CAPA). Aspek kepuasan klien, penanganan keluhan, *service recovery*, audit mutu, persiapan akreditasi, analisis kesenjangan, dan perbaikan berkelanjutan turut dibahas sebagai satu kesatuan tata kelola pelayanan.

Disusun dengan pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE), buku ini tidak hanya membantu pembaca memahami konsep, tetapi juga melatih kemampuan menganalisis risiko, memecahkan masalah, menyusun dokumen pelayanan, mengukur capaian mutu, dan merancang tindakan perbaikan yang operasional. Studi kasus, aktivitas diskusi, simulasi, latihan soal, proyek, audit mini, serta asesmen berbasis capaian pembelajaran menjadikan buku ini relevan untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata pengelolaan TPMB.

Buku ini dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, pengelola TPMB, dan tenaga kesehatan yang ingin memperkuat kompetensi manajerial dalam penyelenggaraan pelayanan. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu membangun tata kelola TPMB yang taat regulasi, berpusat pada klien, berbasis data, responsif terhadap risiko, serta konsisten dalam menjaga mutu dan keselamatan ibu, bayi, dan keluarga.

Pengelolaan pelayanan kebidanan tidak hanya menuntut kecakapan klinis, tetapi juga kemampuan manajerial, kepemimpinan, pengendalian mutu, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada keselamatan pasien. Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat perlu dikelola secara profesional, aman, efektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap berpedoman pada regulasi, standar profesi, etika, serta kebutuhan klien.

Buku ajar Manajemen Pelayanan Kebidanan: Mutu, Keselamatan Pasien, dan Tata Kelola TPMB menyajikan pembahasan sistematis mengenai pengelolaan pelayanan kebidanan, mulai dari konsep dasar manajemen, regulasi dan kewenangan praktik, prinsip tata kelola, perencanaan layanan, penyusunan alur pelayanan dan standar operasional prosedur, hingga pengelolaan sumber daya manusia serta pengembangan kompetensi dan budaya profesional.

Pembahasan selanjutnya mengarahkan pembaca pada penerapan standar mutu, penetapan indikator, pengukuran kinerja, keselamatan pasien, manajemen risiko, serta pencegahan dan pengendalian infeksi. Buku ini juga menguraikan pengelolaan sarana-prasarana dan alat, perencanaan obat serta bahan habis pakai, rekam medis dan kerahasiaan data, sistem rujukan dan jejaring pelayanan, manajemen keuangan TPMB, pelaporan insiden, analisis akar masalah melalui Root Cause Analysis (RCA), serta penyusunan Corrective and Preventive Action (CAPA). Aspek kepuasan klien, penanganan keluhan, service recovery, audit mutu, persiapan akreditasi, analisis kesenjangan, dan perbaikan berkelanjutan turut dibahas sebagai satu kesatuan tata kelola pelayanan.

Disusun dengan pendekatan Outcome-Based Education (OBE), buku ini tidak hanya membantu pembaca memahami konsep, tetapi juga melatih kemampuan menganalisis risiko, memecahkan masalah, menyusun dokumen pelayanan, mengukur capaian mutu, dan merancang tindakan perbaikan yang operasional. Studi kasus, aktivitas diskusi, simulasi, latihan soal, proyek, audit mini, serta asesmen berbasis capaian pembelajaran menjadikan buku ini relevan untuk menghubungkan teori dengan praktik nyata pengelolaan TPMB.

Buku ini dapat digunakan sebagai sumber belajar bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan praktisi, pengelola TPMB, dan tenaga kesehatan yang ingin memperkuat kompetensi manajerial dalam penyelenggaraan pelayanan. Melalui buku ini, pembaca diharapkan mampu membangun tata kelola TPMB yang taat regulasi, berpusat pada klien, berbasis data, responsif terhadap risiko, serta konsisten dalam menjaga mutu dan keselamatan ibu, bayi, dan keluarga.

Penerbit:
**PT OPTIMAL UNTUK NEGERI**
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-15-6 (PDF)
9 786347 927156